CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DT 75 : C2 INTERNE

ÉMETTEUR : DTS DT75

DESTINATAIRES : Chefs d'intervention

VERSION : 01 | **DATE D'APPLICATION :** JJ/MM/AAAA

DATE DE RÉVISION : JJ/MM/AAAA

Guide pratique : Chef d'intervention en réseau de secours BSPP

INTRODUCTION

Ce référentiel version octobre 2024 se veut être une aide pour les Chefs d'Intervention (CI) de la Croix-Rouge française à Paris pour effectuer des missions dans les centres de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Son contenu compose le programme de formation initiale aux différentes procédures en service à la BSPP. Il est notamment inspiré du référentiel BSP 118.1.

Il est à noter que ce référentiel est généraliste, et que, de ce fait, certaines procédures différentes ou pratiques d'usage peuvent être mises en place selon le groupement d'incendie et de secours auquel appartient le Centre de Secours (CS). Il omet également volontairement des procédures très spécifiques ou dont l'usage est rarissime dans le cadre de nos actions.

Chaque chef d'Intervention est invité à rédiger, à partir de ce référentiel, son propre aide-mémoire personnel et à partager ses enseignements avec ses pairs.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION **1**
TABLE DES MATIÈRES **2**
GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA BSPP **4**
PRÉPARATION DE LA VACATION **5**
En amont 5
Présentation au CS et prise de garde 5
Procédures radio CRF 6
PROCÉDURES ET MESSAGES **8**
Généralités 8
Les messages 8
Intervention de routine 9
Message de demande de moyens 10
Message de renseignement 13
Annuler / corriger un message 15
Équipage en danger 15
DÉPART EN INTERVENTION **16**
Ronfleur et conduite à tenir 16
Ordre de départ 16
Parcellaire 17
Trajet 18
Départ par radio 18
Difficultés à rejoindre l'intervention 19
Non présenté au bout de 10 minutes 19
Présentation spontanée lors d'un trajet, équipage disponible 20
Présentation spontanée durant un départ en intervention 20
Équipage requis par un tiers alors qu'une intervention est en cours 21
Intervention sur voie rapide 21
Procédure ACR par message radio général 23
PRÉSENTATION ET DÉROULEMENT DE L'INTERVENTION **24**
Présentation sur un autre secteur / groupement 24
Demande de confirmation d'appel et d'adresse 24
Intervention déjà prise en charge 25
Intervention à plusieurs engins 25
Intervention médicalisée 26
Accident de circulation 26
Intervention sur un mineur 28
Accident de travail 28
Arrêt Cardio-Respiratoire 29
Victime décédée 29
BILAN, CONTACT ET FIN D'INTERVENTION **31**

Rédaction de la fiche bilan.....31
Coordination médicale.....31
Victime laissée sur place.....32
Police demandée non présentée.....32
Demande d'une escorte motorisée.....32
Évacuation et inscription à l'hôpital.....33
Délai d'attente à l'hôpital supérieur à 30 minutes.....34
Message de rentrée et compte rendu d'intervention.....34
Rapport d'intervention ADAGIO.....35
Administratif ACR.....37
FIN DE VACATION.....38
CONDUITES À TENIR ET PROCÉDURES PARTICULIÈRES.....39
Panne ou accident de VPSP.....39
Plusieurs victimes / plusieurs engins.....39
Victime de forte corpulence.....40
Plateforme d'interprètes de la BSPP.....40
Découverte d'arme(s) ou de stupéfiant(s).....40
Intervention sur un policier/gendarme / militaire / personnel du corps (BSPP).....41
Relevé positif du détecteur de CO.....41
Personne menaçant de se jeter dans le vide ou tombée avec notion de hauteur.....41
Intervention sous métro / RER / train.....42
Intervention avec hélicoptère.....43
Demande du CO de libérer la fréquence SGAP OPS.....43
Plan rouge.....43
NUMÉROS ET ADRESSES UTILES (BSPP).....44
NUMÉROS ET ADRESSES UTILES (HÔPITAUX).....45
CAS DE CONTACT ET DÉPLACEMENT DE L'ONYX.....46
ANNEXE : LES GROUPES BSPP.....47
ANNEXE : STATUS ANTARES.....48
ANNEXE : EXEMPLES DE MESSAGES DE RENTRÉE.....49
ANNEXE : LES CODES RETOURS INTERVENTION (CRI).....50
ANNEXE : CAS CONTACT OGC (NON EXCLUSIFS) LIÉS AU CONTEXTE TERRORISTE ET SOCIAL.....52
ANNEXE : LES GRADES À LA BSPP.....53
ANNEXE : LES TYPES D'ENGINS À LA BSPP.....54
ANNEXE : GLOSSAIRE.....56
ANNEXE : HISTORIQUE DU DOCUMENT.....58

GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LA BSPP

Bref historique :

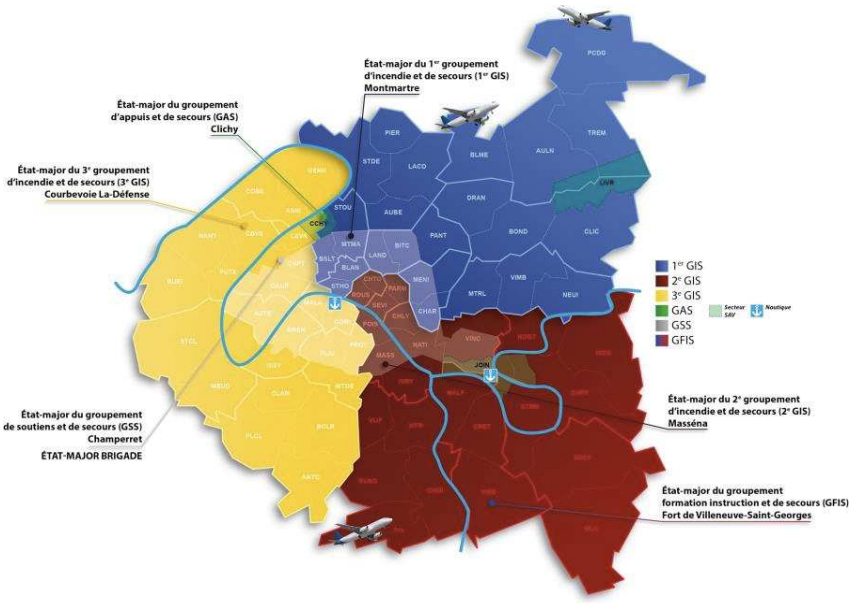
- 1er juillet 1810 : Incendie de l'ambassade d'Autriche.
- 18 septembre 1811 : Napoléon Ier ordonne la création du bataillon des Sapeurs-Pompiers de Paris par décret impérial.
- 1er janvier 1867 : Le bataillon devient régiment des Sapeurs-Pompiers de Paris (2 Bataillons à 6 Compagnies - 50 officiers / 1 498 hommes du rang).
- 1er mars 1967 : Le régiment devient la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, réorganisation de la région parisienne.
- 1er janvier 1968 : Prise en compte de la nouvelle zone de responsabilité étendue à la petite couronne : 6 000 hommes répartis dans 78 centres de secours.
- 1er janvier 1972 : Regroupement des 6 bataillons en 3 groupements d'incendie et de secours.
- En 2023, la BSPP traite plus de 1,4 millions d'appels par an, pour environ 500 000 interventions (soit plus de 1400 / jour), dont 82% liées au secours à personnes.

Organisation et structuration :

La BSPP couvre un territoire de 760 km^2, 124 communes, 7 millions d'habitants, 2 millions de Franciliens et 50 millions de touristes. Elle emploie 8500 femmes et hommes. Ses 71 Centres de Secours sont répartis en 3 Groupements d'Incendie et de Secours (GIS). Un groupement est ensuite subdivisé en compagnies avec un PC de compagnie, auquel sont rattachés 1, 2 ou 3 Centres de Secours. Ces notions permettent de comprendre notre indicatif en vacation.

Exemple : Au sein du 2e GIS (G2) dont l'état-major se situe à Masséna, se trouve la 1ère compagnie dont le PC est Chaligny, auquel sont rattachés les CS Nativité et Vincennes. Ainsi, l'indicatif radio pour l'équipe en vacation au CS de Chaligny sera "Croix-Rouge française 0101" (prononcé 101 à la radio). 01 pour première compagnie, 0 car il s'agit du PC de compagnie, puis 1 car premier engin de la CRf dans ce CS.

Pour le 1er engin CRf du CS de Montmartre (PC de la 9e cie), même principe : Croix-Rouge française 0901. Pour le CS de Plaisance, qui est le 2e CS de la 3e compagnie, l'indicatif est donc 0321.



Les associations agréées de sécurité civile représentent 11 190 départs par an environ sur le secteur brigade, dont 5000 pour la Croix-Rouge française à Paris. Les autres associations participant à la couverture des centres de secours BSPP sur Paris sont la Protection Civile, l'Ordre de Malte et la Fédération Française de Sauveteurs Secouristes.

PRÉPARATION DE LA VACATION

En amont

La constitution, la composition et les règles liées aux équipages sont définies dans le *Règlement du Réseau de Secours* de la DT75. Il convient néanmoins d'en rappeler les points essentiels auxquels le CIR doit veiller en amont de sa vacation :

- Équipage comportant 1 CIR BSPP, 1 CH VPSP, 1 équipier secouriste PSE2, 1 secouriste PSE1, et optionnellement un cinquième membre d'équipage qui peut être un évaluateur, un équipier secouriste ou un stagiaire (PSC1). Tous sont à jour dans leurs nominations par leur autorité d'emploi et dans leur formation continue.
- Uniforme propre complet et réglementaire, y compris la chasuble, chaussures de sécurité (montantes au-dessus des chevilles) sombres (noires ou marrons), tenue propre, cheveux longs attachés, pas de bijoux, pas d'écharpe, barbe rasée ou taillée pour les hommes.
- Tout l'équipage détient une pièce d'identité officielle sur lui.
- Aucun mineur n'est autorisé en garde BSPP.
- Ouverture de la garde confirmée par la DT75, mission déclarée sur PEGASS, équipage conforme inscrit et validé.

Le CIR doit s'assurer que l'équipage reçoive, au plus tard la veille de la garde, un message de consignes comprenant un rappel du règlement vestimentaire, la possession obligatoire d'une pièce d'identité, un rappel des horaires et une heure et un lieu du rendez-vous. L'heure de rendez-vous doit prendre en compte le retard éventuel de certains bénévoles, le temps de vérification du matériel, le trajet vers le Centre de Secours, la circulation, le temps du briefing, et le temps de la mise en place avant d'être effectivement disponible.

Présentation au CS et prise de garde

Un Centre de Secours est une enceinte militaire avec ses règles de fonctionnement et sa hiérarchie définies. Il est nécessaire, par respect envers les militaires de la BSPP et pour l'image de la CRf, de respecter des règles élémentaires :

- L'équipage devra se présenter au Centre de Secours au moins 15 min avant le début de la vacation afin de s'assurer d'être opérationnel à l'heure.
- Dire bonjour à chaque personnel rencontré.
- Vouvoyer les interlocuteurs.
- Être discret : l'équipage CRf est invité et à ce titre ne doit pas perturber la vie de la caserne.
- Respecter la hiérarchie militaire, *a minima* être capable de différencier hommes du rang, sous-officiers et officiers (voir annexe « grades militaires »).

Les interlocuteurs du CIR BSPP au sein du Centre de Secours sont les suivants :

- **Stationnaire**, au Poste de Veille Opérationnelle (PVO) : est le 1er contact téléphonique ou physique, il prend les rentrées d'interventions et fait sonner l'équipage pour les interventions.
- **Garde remise** : Il est le référent matériel du CS. C'est lui qui fera percevoir la bouteille d'O2 et apportera le complément de matériel utilisé sur intervention si nécessaire.
- **Sergent de jour** : Il est le référent technique du chef d'agrès en cas de doute sur les rapports et procédures d'interventions, il est en outre le référent pour tout problème logistique ou relationnel. En cas de besoin, il peut être contacté par l'intermédiaire du PVO. S'il est indisponible, le PVO basculera la demande vers le chef de garde, voire l'officier de garde compagnie.
- **Chef de garde** : il est le chef de la garde incendie du jour dont il établit le planning journalier et contrôle la conformité. Il s'assure de faire réaliser les missions de la journée au sein du CS. Il est garant de la couverture opérationnelle du secteur pour la durée de sa garde (réseau incendie, disponibilité des engins et personnels, etc.)

- **Officier de garde compagnie** : il se déplace sur toutes les interventions importantes et/ou à caractère exceptionnel. En cas de forte activité, il peut également demander, via le groupement (Golf) ou le PVO du CS, à être tenu informé par téléphone de l'évolution d'une intervention.

Afin de pouvoir se passer disponible, le CIR doit :

- Procéder à la perception d'une bouteille d'O_2 de 5 L, en échange d'une bouteille provenant du VPSP. L'échange sera fait dans le sens inverse en fin de vacation. Pour se faire, il convient de solliciter le garde remise par l'intermédiaire du stationnaire.
- Percevoir et vérifier une radio ANTARES chargée, qui reste en charge au PVO hors intervention. Vérifier notamment que la radio est déjà sur la bonne fréquence (SGAP OPS X en fonction du CS où la vacation a lieu), la radio dédiée à la CRf étant très régulièrement utilisée par d'autres engins sur les canaux tactiques en notre absence.
- Percevoir une tablette eFibi, vérifier ses identifiants (code PIN 0000, code de déverrouillage 1811), son bon fonctionnement général et la charge de la batterie.
- Apparier par Bluetooth le tablette du Schiller DT7 lors de la vérification du matériel. Cela vous permettra de transmettre l'ECG via la tablette si le DT7 ne capte pas, ou de faciliter la traçabilité du bilan de surveillance.
- S'assurer de détenir un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel. Attention, il est de plus en rare qu'il y en ait de prévu pour les équipages associatifs au sein des casernes, il est donc préférable de s'assurer d'en disposer dans le VPSP avant de quitter le local.
- Vérifier qu'il détient tout l'administratif obligatoire BSPP, et si besoin faire le complément au PVO :
    - Un administratif papier, en cas de défaillance eFibi :
        - Fiches bilans en quantité suffisante.
        - 2 fiches DSA de l'année en cours et du bon groupement.
        - 2 fiches accouchement.
    - Fiches décharges en quantité suffisante.
    - Fascicules BSPP d'accompagnement d'un décès suite à ACR, qui présentent les condoléances de la BSPP et de l'équipe d'intervention et résument les procédures administratives à effectuer pour déclarer le décès et assurer la prise en charge du corps par les autorités compétentes.
    - Ne pas oublier que la fiche d'arrêt cardio-respiratoire CRf est également à avoir dans l'administratif.
    - Bon de prise en charge provisoire de matériel (ST25bis) : à remplir en deux exemplaires si vous laissez du matériel à l'hôpital (plan dur, attelle…) afin de pouvoir le récupérer par la suite.
- Prendre connaissance des procédures particulières : plan hivernal, notes du groupement, etc.
- Vérifier sur le parcellaire si des points particuliers sont à prendre en compte sur la circulation : voie fermée en travaux, zone à éviter, etc.
- Donner son numéro de portable et son nom au stationnaire, pour pouvoir être contacté en toute situation.
- Remplir la fiche rationnaires (soit à la prise de garde, soit avant le repas) — mais sans indiquer les identités des bénévoles (mettre « CRF » comme nom).

Dès lors que l'équipage est conforme et briefé, le matériel et l'administratif vérifiés, le CIR peut se passer disponible auprès du stationnaire, à l'heure de début de vacation prévue.

Procédures radio CRF

Lorsque votre vacation a lieu en l'absence d'une régulation du réseau radio CRf, les messages à passer sur les ondes sont minimaux :

- Prise d'écoute, déplacements du VPSP vers le centre de secours, présentation au centre de secours, changement d'indicatif.
- Départs en intervention : *« À tous, la Croix-Rouge française de Chaligny, partie 10 rue de Lappe, Paris 11e, personne malade, voie publique. »*

- Fin de vacation, retour à l'indicatif de section, déplacement vers le garage.

Dans certaines situations particulières, une régulation CRf territoriale dont l'indicatif est PC75 peut être activée. La Direction Territoriale ou le cadre de permanence préciseront alors si les CS sont soumis à des consignes particulières auprès de cette régulation, ou s'ils conservent les procédures habituelles.

PROCÉDURES ET MESSAGES

Généralités

Les objectifs et priorités d'une intervention en BSPP sont les mêmes qu'en réseau de secours SAMU : sécurité de l'équipage, non-aggravation de l'état de la victime, compte-rendu aux autorités lorsque cela est nécessaire. Les réflexes déjà acquis par un chef d'intervention réseau sont placés dans un cadre de procédures et d'administratif spécifique, mais ne varient pas dans leurs objectifs.

La première différence repose sur les interlocuteurs : la BSPP est le gestionnaire opérationnel de l'équipage et, à ce titre, est toujours le premier interlocuteur. Toutefois, le cadre de permanence territorial (Onyx) a aussi comme rôle d'intervenir en soutien aux équipages Croix-Rouge en garde BSPP. Le Chef d'Intervention peut donc contacter l'Onyx pour tout conseil ou interrogation qu'il ne souhaite pas ou ne peut pas formuler auprès de ses interlocuteurs BSPP.

Cela veut dire que :

- Toute demande de moyen ou compte-rendu urgent est fait en premier à la BSPP : les autorités Croix-Rouge sont contactées dans un second temps, pour information ou pour déclenchement de procédures internes particulières. Par exemple, en cas de prise en charge d'un ACR, la priorité est de demander l'équipe médicale et les éventuels moyens en renfort, avant de prévenir ensuite l'Onyx.
- En cas de doute ou de questionnement : le contact privilégié du CIR est le sergent de jour (à contacter par l'intermédiaire du PVO) qui saura l'orienter et l'aider si besoin. Toutefois, l'Onyx est à disposition du CIR si celui-ci préfère s'adresser à un interlocuteur interne.
- Néanmoins, la Croix-Rouge française restant l'autorité d'emploi, ce sont ses procédures et règlements qui priment en cas de discordance. Il est par exemple rappelé que nous sommes soumis à l'application du PSE2 et non du BSP 200.2.
- Les principes de la Croix-Rouge française restent toujours intangibles et doivent être appliqués.

La seconde différence repose sur la procédure radio spécifique de la BSPP qui sera abordée dans les chapitres suivants. Il est important que le CIR garde en tête que son action de secours est sa priorité absolue : mieux vaut passer un message incertain et se concentrer sur sa prise en charge, que délaisser la victime et l'équipage pour se concentrer sur sa procédure.

Les messages

L'exploitation du réseau radio de la Brigade est assurée sur le principe d'un réseau dirigé organisé à partir de 3 niveaux de stations directrices : Centre Opérationnel, Centre de Suivi Opérationnel (au niveau du groupement groupement, et PVO (au niveau du CS). Il convient de respecter quelques règles élémentaires lors des échanges radios :

- Émission sur la fréquence « SGAP-OPS » du numéro du groupement où vous vous situez
- Vérifier qu'un échange n'est pas déjà en cours avant de transmettre, sauf message urgent et prioritaire à introduire comme suit:

  "URGENT, URGENT, URGENT, Golf 3 ici la Croix-Rouge Française 321 de Plaisance parlez"

  À noter, qu'il s'agit pour un équipage CRf d'une situation purement exceptionnelle, la désignation des moyens au départ étant conçue pour ne pas engager un VSAV ou un moyen associatif sur des interventions où celui-ci se trouverait dès son arrivée en moyens dépassés et contraint de passer ce type de message.
- Pour qu'il ne soit pas tronqué, la transmission d'un message radio doit débuter après le déclenchement du relais, soit environ trois secondes après l'appui sur la pédale d'émission (attendre que le voyant à côté de l'écran passe au rouge lorsque l'on appuie sur la pédale d'émission avant de parler).
- Les messages sont transmis à vitesse lente, de façon à permettre aux stationnaires et aux opérateurs de les prendre en note.

- Votre interlocuteur principal en phonie sera le CSO (« Golf ») ; en cas de problème avec la radio, il faudra contacter le CSO par téléphone pour passer les différents messages. Si cela n'est pas possible, la dernière solution est de contacter par téléphone le PVO de votre Centre de Secours pour passer votre message.

Il existe 8 types de messages dans les procédures BSPP :

- Message de départ : systématique, passé en statut *
- Message de présentation : systématique, passé en statut *
- Message de demande de moyens : si besoin de renforts, systématiquement en phonie sauf sur ordre du CO (relayé par le PVO) en cas de mode dégradé
- Message d'ambiance : peu fréquent en secours à victime, passé en phonie
- Message de renseignement : si besoin, seul ou avec la demande de moyens ; en phonie
- Message de déplacement : presque systématique, passé en statut *
- Message de disponibilité : systématique, passé en statut *
- Message de rentrée : systématique, passé par le PVO

Les messages annotés d'une * sont ceux qui sont passés en statut, sauf si la situation dégradée nécessite de les passer par phonie (sur demande du CO ou du CSO).

En résumé, seuls les messages de demande de moyens et de renseignement nécessitent un travail particulier. Les autres sont toujours identiques, et majoritairement transmis aujourd'hui par statuts.

Intervention de routine

La très grande majorité des interventions suit une routine de procédure minimale : départ – présentation sur les lieux – transport hôpital – arrivée hôpital – quitte l'hôpital – disponible. Si aujourd'hui tout cela se gère par statuts, le CIR BSPP doit cependant être capable de passer ces messages en phonie, notamment en cas de dysfonctionnement technique. Voici, en statuts et en phonie, les procédures correspondant à ces interventions « de routine » :

Étape de l'intervention	Statut	Message en phonie
Départ en intervention	1	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) partie (tel motif), (telle adresse) »*
Se présente	2	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) se présente »* *« Poste fixe de (Centre de secours) reçu »*
Transport hôpital	5	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) se dirige vers l'hôpital (nom de l'hôpital) »*
Se présente à l'hôpital	6	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) se présente à l'hôpital (nom de l'hôpital) »*
Quitte l'hôpital	25	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) quitte l'hôpital (nom de l'hôpital) »*
Disponible	7	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) est disponible »* *« Poste fixe de (Centre de secours) reçu »*
Rentré	9	Pas de message en phonie.

Concernant le statut 25 – Quitte l'hôpital

- En sortant d'un hôpital qui se trouve sur son secteur, le CIR BSPP passe à la suite ses statuts 25 puis 7 pour se signaler sorti de l'hôpital et disponible dans la foulée.
- En sortant d'un hôpital qui n'est pas sur son secteur, le CIR BSPP passe le statut 25, pour indiquer être en route vers son secteur et passera le statut 7 une fois revenu sur celui-ci.

Dans tous les cas, les deux statuts (25 puis 7) doivent être systématiquement passés.

Message de demande de moyens

Le message de demande de moyens permet de combler un manque opérationnel afin de conduire l'intervention de manière adéquate. Idéalement, il est passé le plus rapidement possible à l'issue de la reconnaissance de sécurité effectuée en arrivant sur les lieux de l'intervention (au maximum dans les 5 minutes suivant la présentation). Il a la priorité sur les autres messages.

Sa composition suit la règle mnémotechnique **SAM : Service – Adresse – Motif**. Par exemple :

CRF : « Golf 1 ici la Croix-Rouge française 901 Montmartre, parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française 901 Montmartre ici Golf 1, parlez ».

CRF : « De la Croix-Rouge française 901 Montmartre, je demande tel moyen, telle adresse (voie publique / tel étage), (tel motif), Golf 1 parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française 901 Montmartre, vous demandez tel moyen, (telle adresse), (tel motif), message reçu à telle heure ».

S'il s'agit d'un engin BSPP, le CSO complètera :

CSO : « Je vous rends compte que tel engin, de tel CS a été sonné ».

CRF : « Reçu, et attendons ».

NB : En fonction de l'organisation interne des groupements, les services publics seront demandés soit par le PVO, soit par le CSO.

Points particuliers :

- Les moyens BSPP doivent toujours être demandés en premier, puis les services publics. Par exemple : *« Je demande un véhicule de secours à victimes et Police, (telle adresse), (tel motif) »*
- Il est possible de demander un moyen BSPP sans motif précis (autrement appelée "demande sèche"), en attendant de passer un message de renseignement plus tard : *« Je demande un engin-pompe (telle adresse) pour un accident grave de la voie publique »*
- Il est également possible de demander un matériel particulier, charge au CSO d'honorer la demande en envoyant le moyen adéquat. En cas de doutes sur le moyen adéquat à demander, ne pas hésiter à contacter le chef de garde au préalable. Par exemple : *« Je demande un défibrillateur automatique externe / un détecteur multi gaz / une échelle à coulisse petit modèle / … (telle adresse) »*
- Il est également possible de faire une demande de moyen pour une mise à disposition en différé ; par exemple pour s'assurer de disposer ultérieurement d'un engin spécifique nécessaire au bon déroulement de l'intervention : *« De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande un moyen élévateur aérien rendu pour (heure d'intervention de l'engin souhaité), secours à un homme malade, urgence absolue, au 4 rue Edmond Rousse, escalier 120, 4ème étage sur cour, Golf 3 parlez ».*
- Si vous demandez plusieurs moyens, il faut les ordonner « du plus gros au plus petit » : par exemple, « *un engin pompe et un détecteur multigaz* ».

Je demande	**Motifs**
« ***Police***, *telle adresse, tel motif* »	Personne agressive envers les secours, personne en état d'ébriété VP, décès certain, décès suspect, ACR sur VP, personne agressée (si la victime souhaite porter plainte), accident de circulation, reconnaissance d'appartement, personne nue sur VP, troubles de l'ordre public sur VP, rixe, différend familial, personne décédée VP, accident du travail (blessé), équipage face à la victime refusant violemment son transport. *Le CIR peut par ailleurs demander la police dès lors qu'il le juge nécessaire.*
« ***Police d'urgence***, *telle adresse, tel motif* »	Agression envers les équipes de secours. *Il doit y avoir un véritable danger imminent pour l'équipe.*
« ***Une escorte motorisée***, *telle adresse, tel motif* »	Transport vers l'hôpital. *Systématiquement à la demande du médecin.*
« ***Un engin de prompt secours***, *telle adresse, tel motif* »	Renfort brancardage (3 personnels seulement), renfort massage
« ***Un moyen de transport non médicalisé***, *telle adresse, tel motif* »	Transport (si deuxième victime non transportable par CRF)
« *Un engin pompe*, *telle adresse, tel motif* »	Ouverture de porte, reconnaissance d'appartement renfort brancardage (6 personnels) *Après avoir appelé le chef de garde pour demander conseil et se faire confirmer l'engin le plus approprié*
« ***Moyen élévateur aérien***, *telle adresse, tel motif* »	Brancardage, reconnaissance d'appartement *Important : Toujours confirmer avec le chef de garde d'abord, notamment pour prendre en compte dans le choix de l'engin les conditions d'accessibilité, de hauteur et de manœuvre, le poids de la victime, etc.* *Il faudra aussi confirmer avec lui la compatibilité entre votre brancard et la nacelle, et si votre brancard n'est pas compatible demander un moyen de transport non médicalisé.*
« ***Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux***, *telle adresse, tel motif* »	Brancardage *Après avoir appelé le chef de garde pour demander conseil et se faire confirmer l'engin/le moyen le plus approprié. Un engin pompe sera demandé en renfort. Le chef d'agrès de l'EP permettra de confirmer la nécessité de faire intervenir le GRIMP et fournira à minima une aide au commandement, s'il ne reprend pas le commandement des opérations de secours (ce qui sera presque toujours le cas).*

Je demande	**Motifs**
« ***Un groupe d'intervention chimique***, *telle adresse, tel motif* » *[ou* ***un groupe d'intervention radiologique****, selon le besoin]*	Pour une levée de doute et des conseils Accident de la voie publique impliquant un véhicule hybride. *Toujours contacter le chef de garde avant de demander ce type de moyens.*
« ***Le véhicule de transport bariatrique*** *pour le transport d'une personne à forte corpulence, telle adresse* »	Pour le transport d'une personne de plus de 185 kg. *Sonné à la demande du CIR BSPP après passage de bilan à la coordination médicale. L'engin part de la base de Limeil-Brévannes (94), voire des SDIS voisins si indisponibilité de l'engin BSPP. Prévoir du délai. L'équipage CRf doit ensuite suivre le VTBA jusqu'à l'hôpital d'évacuation.*
« ***Une équipe médicale****, telle adresse, tel motif,* ***coordination médicale non contactée*** »	Cas urgent et / ou impossibilité de joindre la coordination médicale (demande sèche). *En situation très exceptionnelle uniquement.*
« ***Complément de départ****, telle adresse, tel motif* »	*Solution à privilégier si vous n'êtes pas certain des moyens nécessaires pour prendre en charge une intervention complexe. Le motif doit être assez explicite pour que les bons renforts soient envoyés.*

Concernant la demande de moyen élévateur aérien

La Brigade possède plusieurs moyens élévateurs aériens permettant le brancardage : échelle pivotante automatique à nacelle (EPAN) et bras élévateur articulé (BEA). Le choix entre les différents moyens dépend de paramètres complexes (hauteur, accessibilité, poids à transférer, compatibilité brancard/nacelle, etc) dont la pris en compte dépasse les attendus du chef d'intervention CRf. Toute demande de moyen élévateur aérien doit donc se faire après conseil par le chef de garde.

Présentation des moyens demandés

Gardez bien en tête le principe de « tiroir » dans les messages BSPP : si un moyen a été demandé, cela a ouvert un tiroir qu'il faut refermer en précisant que le moyen s'est présenté (sauf engins BSPP puisqu'ils se sont présentés eux-mêmes).

Option n°1 : Présenter le moyen non BSPP dès son arrivée : pratique quand vous n'attendez qu'un seul moyen sur l'intervention.

- *« Golf 1 ici la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, parlez ».*
- *« Croix-Rouge française 901 de Montmartre ici Golf 1, Parlez ».*
- *« De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre :*

« La police se présente »
« Compagnie républicaine de sécurité se présente »
« Officier de police judiciaire se présente »
« Équipe médicale Necker se présente »
« Golf 1 parlez ».

Option n°2 : Présenter les moyens non BSPP à la fin de l'intervention, avant de quitter les lieux : convient mieux lorsque vous attendez plusieurs moyens sur l'intervention, plutôt que présenter chacun individuellement.

– « Golf 1 ici la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, parlez ».

– « Croix-Rouge française 901 de Montmartre ici Golf 1, parlez ».

– « De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre :
« Police présentée à telle heure.
« Compagnie républicaine de sécurité présentée à telle heure.
« Officier de police judiciaire présenté à telle heure.
« Equipe médicale Necker présentée à telle heure.
« Golf 1 parlez ».

En cas d'intervention complexe, il est possible d'émettre un message de demande de moyen pour obtenir le renfort d'un chef d'agrès expérimenté pour aide au commandement. Une telle demande peut aller jusqu'à l'OGC au besoin. Il conviendra de toujours appeler le chef de garde au préalable pour se faire conseiller sur le bon niveau d'appui à demander.

« De la Croix-Rouge française 321 Plaisance, je demande un engin pompe pour aide au commandement. »

Message de renseignement

Un message de renseignement doit être passé pour signaler toute évolution notoire sur une intervention, ou lors d'une intervention longue (plus de 45 minutes) pour rendre compte de l'avancée des opérations.

Message de renseignement simple

Le message de renseignement permet d'informer le CSO du déroulement de votre intervention. Il n'est utilisé que lorsque l'intervention présente un caractère particulier ou nécessite d'autres moyens. Cela concerne donc en secours à victime :

- Les interventions médicalisées, dont ACR et parturiente
- Les décès certains
- Les accidents de circulation *(sauf cas particulier : AVP avec 1 victime UR que vous transportez à l'hôpital)*
- Les interventions à multiples victimes (à partir de 2)
- Le cas de la personne menaçant de se jeter dans le vide
- L'intoxication au CO
- Tout ce qui pourrait sortir de l'ordinaire

La composition du message de renseignement simple se fait comme suit :

CRF : « Golf 3, ici la Croix-Rouge française 321 Plaisance, parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française 321 Plaisance, ici Golf 3, parlez ».

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 Plaisance, secours à un homme malade, urgence absolue, (telle adresse, tel étage), et attendons équipe médicale, Golf 3 parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française de Plaisance, secours à un homme malade, (telle adresse, tel étage), et attendons équipe médicale, message reçu à (telle heure) ».

CRF : « Correct, et attendons ».

NB : si une équipe médicale est au départ des secours, il n'est pas nécessaire de passer ce message de renseignement puisque l'information est déjà connue. Elle sera en revanche bien présentée dans un message ultérieur.

NB : le message de renseignement sera également utilisé pour signaler, le cas échéant, le statut particulier d'une victime prise en charge : secours à une autorité (préciser la fonction), secours à un policier, secours à un militaire, secours à un sapeur-pompier de Paris.

Message de renseignement et de demande de moyens

Toutefois, dans tous les cas listés ci-dessus hormis la « simple » médicalisation, une demande de moyens doit forcément être faite pour gérer ces interventions. Le plus simple et pratique est donc de coupler la demande de moyens au message de renseignement, de sorte à ne passer qu'un seul message :

CRF : « Golf 3, ici la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française 321 de Plaisance, ici Golf 3, parlez ».

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande Police, (telle adresse, voie publique), secours à un homme en arrêt cardio-respiratoire, et attendons équipe médicale, Golf 3 parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française 321 de Plaisance, vous demandez Police, telle adresse, voie publique, secours à un homme en arrêt cardio-respiratoire, et attendons équipe médicale, message reçu à (telle heure) ».

CRF : « (Telle heure), correct, attendons ».

Attention de ne pas oublier de présenter les moyens demandés si nécessaire comme expliqué dans le chapitre précédent.

Dénombrement terrain dans le message de renseignement

Dans le cas des accidents de circulation et des interventions à multiples victimes, le message de renseignement doit comporter le nombre de victimes et leur état. On ne parle pas de « bilan » (qui sera consolidé par l'état major) mais de « dénombrement terrain ».

Il existe deux cas de figure : soit annoncer immédiatement un dénombrement terrain dont vous êtes certain, soit annoncer un dénombrement terrain provisoire qui peut être amené à évoluer car vous ne pouvez pas, à cet instant, connaître toutes les victimes et leur état (intoxication CO, AVP avec incarcération, etc.).

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande police, (telle adresse), pour accident de la circulation impliquant 1 véhicule de tourisme seul, 1 victime urgence relative, Golf 3 parlez ».

ou

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande 1 engin pompe, 1 camion de désincarcération, 1 véhicule de secours à victimes, et police, (telle adresse), accident de la circulation impliquant 3 véhicules de tourisme, dénombrement terrain provisoire 1 victime urgence absolue, 2 victimes urgences relatives, et attendons équipe médicale, Golf 3 parlez »

Clôture du message de renseignement

Selon le principe de toujours fermer un tiroir qui a été ouvert, tout message de renseignement appelle un autre message de renseignement à la fin de l'intervention. Les pratiques selon les groupements varient sur ce point, néanmoins il vaut mieux opter pour une procédure trop rigoureuse que pas assez.

Dans ce message il est possible d'indiquer :

- Le dénombrement terrain définitif s'il y a eu dénombrement terrain provisoire
- La suite donnée (sauf si 1 seule victime UR et que vous assurez son transport)
- L'heure de présentation des moyens (non BSPP) demandés

Selon les cas cela peut donc être simplement :

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, police présentée à (telle heure), Golf 3 parlez. »

ou être un peu plus riche :

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, dénombrement terrain définitif :
- 1 Urgence absolue transportée par équipe médicale Necker présentée à (telle heure),

- *2 Urgences relatives transportées par moyens de transport non médicalisés*,
- *Police présentée à (telle heure)*,
- *Golf 3, parlez ».*

NB : Message riche = intervention complexe = des chefs d'agrès BSPP avec vous. N'hésitez pas à demander conseil au moment d'élaborer ces messages qui n'ont pas de caractère d'urgence.

Annuler / corriger un message

Il peut arriver que vous commenciez à passer un message avant de vous rendre compte que celui-ci n'est plus nécessaire. Par exemple commencer une redemande police alors que celle-ci se présente. Pour interrompre votre message, utilisez la phrase suivante :

> *« Golf (X), annulez la transmission ».*

Si vous faites une erreur dans votre message, vous pouvez la corriger immédiatement de la façon suivante :

> *« De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande police, 1 quai de la Râpée… Correction, lire 30 quai de la Râpée, pour une personne en état d'ébriété sur la voie publique, Golf 2 parlez. »*

Enfin, si le CSO collationne votre message avec une erreur, vous pouvez également la corriger afin de vous assurer qu'il détienne l'information correcte.

> *CSO : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande police métro quai de la râpée, pour une personne en état d'ébriété sur la voie publique, message reçu à (telle heure) »*
> *CRF : « Négatif, lire 30 quai de la râpée, Golf 2 parlez »*
> *CSO : « 30 quai de la râpée, message reçu à (telle heure) »*
> *CRF : « (Telle heure), correct et attendons ».*

Il est également possible de compléter ou modifier a posteriori un message déjà émis en utilisant les formules:

> CRF : "Additif/Modification au message de (indiquer l'heure du message concerné), (contenu de l'ajout/modification)".

Enfin, vous pouvez faire corriger un message passé sur intervention par un appel du PVO au CSO. Cela vous permet de faire une correction à tête reposée, après votre intervention (mais avant que celle-ci soit clôturée !), et après avoir pris conseil si vous avez un doute.

Équipage en danger

Le CIR BSPP doit demander un renfort police. À noter l'importance des termes employés dans les messages qui conditionnent les effectifs mis en œuvre pour y répondre :

- *« personne agressive envers les secours »* : selon les termes du message il s'agirait d'une personne isolée. Il est alors convenu l'envoi, par défaut, d'une patrouille policière (trois personnels).
- *« équipage pris à partie par la foule »* : le nombre d'individus hostiles est élevé et potentiellement supérieur à l'effectif de l'équipage qui se trouve en moyens dépassés et danger immédiat. Il est alors défini que seront envoyées plusieurs patrouilles avec du matériel à même de disperser une foule agressive.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, il est également possible de demander un engin pompe en supplément de la police. Le délai d'arrivée d'un moyen BSPP étant fréquemment inférieur à celui d'un moyen police, cette solution intermédiaire est à même d'offrir à l'équipage CRf des conditions de sécurité (six personnels BSPP en tenue de feu) permettant d'attendre l'arrivée de la police plus sereinement.

NB : il existe sur les radios BSPP un bouton rouge (en haut à droite du portatif). Contrairement aux apparences, il n'est pas utilisé dans les procédures actuelles en cas de danger pour l'équipage.

DÉPART EN INTERVENTION

Ronfleur et conduite à tenir

Sur l'ensemble du secteur BSPP, le ronfleur indiquant le départ en intervention d'un équipage Croix-Rouge doit être : ***ronfleur – 1 sonnerie courte – 1 sonnerie longue – 1 sonnerie courte***. Il convient de vérifier auprès du PVO en début de vacation que c'est bien ce signal qui sera utilisé, notamment s'il s'agit d'un Centre de secours peu habitué à notre présence.

Lors de l'émission de ce signal, l'ensemble de l'équipage cesse ses activités courantes. Le Chef d'Intervention se rend au PVO pour récupérer l'ordre de départ, la radio BSPP, la tablette et tout complément d'information disponible auprès du stationnaire. Le reste de l'équipage se rend au VPSP, sans courir, et avec interdiction absolue d'emprunter la perche de feu (historique d'accidents).

Le conducteur veille à ne mettre ses gyrophares qu'au niveau du PVO, surtout de nuit. Il coupera également le bip de recul dans l'enceinte du centre de secours.

Ordre de départ

L'ordre de départ vous est remis au PVO et contient toutes les informations nécessaires à votre action de secours. Il se décompose ainsi :


Mission BSPP - Procédure Blanche

PREMIERS DEPARTS - SECOURS A VICTIME -

302 - Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...)

CRF 0101 (CRF_1_CHLY) Votre indicatif

accès à l'intervention pour le moyen sélectionné (y compris zdi, multi-adressage etc) :

PLACE D'ALIGRE 75012 12EME ARRONDISSEMENT

heure de validation ode : 15/08/2017 15:19:25 Heure de validation

cstc : CHLY
Centre de Secours
Territorialement Compétent

n° intervention : 12 218 626 n° d'inter (à reporter sur fiche bilan)

1er départ : 302 - Personne blessée lieu public (VP, ERP, ...) Motif

adresse d'intervention : PLACE D'ALIGRE 75012 12EME ARRONDISSEMENT Adresse

parcellaire
N37f (Page n° 2306) Repère sur le plan mural

numéro requérant : 0651 Téléphone portable numéro impliqué : 0651

heure de décroché : 15/08/2017 15:18:28

informations requérants : Complément d'info : codes, accès, motif d'appel...
sur vp // h40 aine // chute meca // pliae tete // malaise

consignes chefs d'agrès :
Ressource(s) Dotation(s) : engin pompe à 6 hommes exclu(e)
Règle d'engagement : Procédure BLANCHE
Observations :

engins complémentaires : Liste des engins engagés sur l'intervention
CRF_1_CHLY ;

Le code motif d'alerte (CMA) indiqué en haut à gauche (ici : 302 Personne blessée lieu public) indique comment l'intervention a été codée par l'opérateur du 18/112. Selon le CMA, des moyens différents seront engagés. En particulier, les moyens associatifs ne sont pas envoyés sur certains CMA.

Un QR Code en bas à droite de l'ordre de départ permet, en le scannant avec un smartphone, d'ouvrir un itinéraire pour rejoindre le lieu de l'intervention. Sans en faire un usage abusif, cela peut être une aide précieuse lors d'interventions désectorisées plus éloignées. La même fonctionnalité est disponible sur l'application eFibi de la tablette.

Différentes catégories de procédures existent, indiquées par des couleurs :

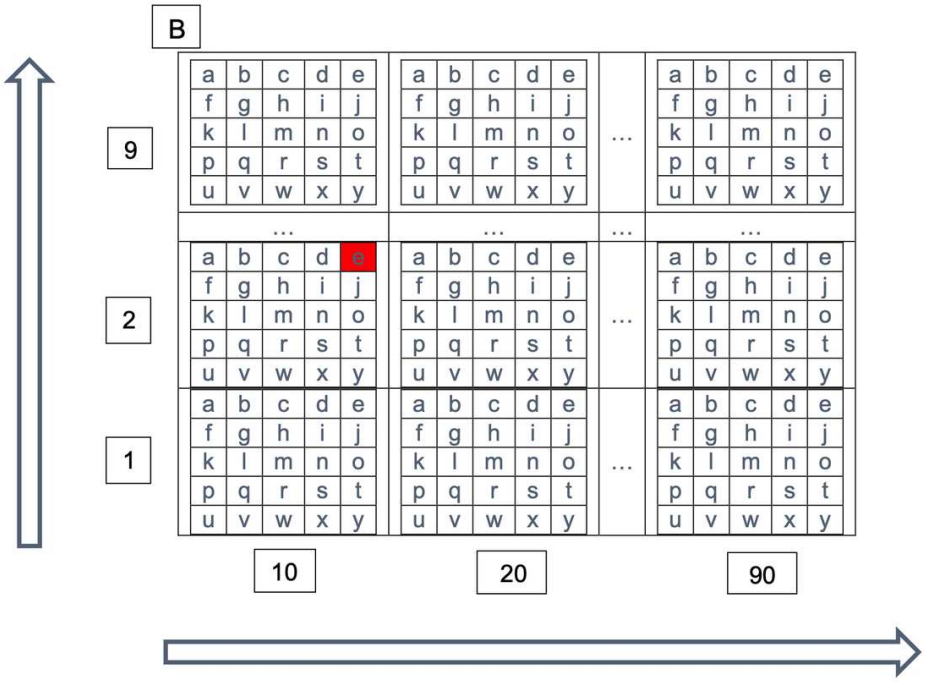
- Procédure rouge : Détresse vitale évidente. La coordination est avertie d'emblée et décide ou non de déclencher une équipe médicale.
- Procédure orange : Suspicion de détresse vitale. Après l'envoi du moyen de prompt secours, une conférence à 3 est organisée avec le médecin coordinateur qui attend un bilan rapidement et peut décider d'envoyer, ou non, une équipe médicale. La procédure orange va donc évoluer vers une procédure rouge ou une procédure blanche.
- Procédure blanche : Il s'agit du cas général, d'un appel entrant dans les missions de la Brigade mais sans signes de détresse vitale potentielle ou évidente lors de l'appel.
- Procédure verte : Il s'agit d'un appel que le CO classe en « hors mission brigade », ne contenant aucune détresse immédiatement décelable par l'opérateur, mais qui nécessite une évaluation médicale. L'appel est alors basculé vers le SAMU. Après évaluation par le SAMU, l'appel peut finalement donner lieu à une intervention (il s'agit alors d'un retour de procédure verte).
- Procédure grise : très rare, il s'agit d'une intervention concernant une adresse inexistante (potentiellement rue nouvellement créée et inconnue du logiciel). Solution : se débrouiller pour faire au mieux, avec le soutien du PVO…

Parcellaire

Dans chaque PVO se situe un grand parcellaire décrivant l'ensemble du secteur et une partie des secteurs voisins ; le secteur du CS est toujours en fond jaune.

Des parcellaires complets des secteurs voisins sont disponibles sur demande (dans des classeurs).

Afin de localiser le lieu de l'intervention, il faut rechercher le carroyage indiqué sur le ticket de départ. Les carroyages fonctionnent de la façon suivante, avec les chiffres de dizaines en abscisse (axe horizontal), et les chiffres unitaires en ordonnée (axe vertical) :



Si mon ticket de départ indique le parcellaire B12e, je cherche le grand carré B, première colonne, deuxième ligne : B + 10 (abscisse) + 2 (ordonnée) = B12.

La meilleure manière de préparer son itinéraire est de prendre les plus grands axes et chercher à minimiser le nombre de changements de direction : cela sera plus simple à retenir et diminuera le risque d'erreur. Le chemin

le plus court n'est pas nécessairement le plus approprié. Attention à bien vérifier les sens de circulation et obstacles éventuels.

En cas d'intervention hors secteur ou besoin de renforts qui viendraient d'un autre secteur, vous entendrez parler du « carré des neuf » : il s'agit de l'ensemble des secteurs limitrophes à un CS donnés. Selon les CS et la géographie parisienne, il se peut d'ailleurs qu'il n'y ait pas neuf secteurs limitrophes. Néanmoins l'expression s'est institutionnalisée et demeure. Des parcellaires de l'ensemble des secteurs du carré des neuf sont disponibles au PVO de chaque CS.

Trajet

L'engagement de la BSPP est d'honorer une présentation sur site dans les 10 minutes suivant le décroché de l'appel. Toutefois, la priorité absolue du chef d'intervention est la sécurité de son équipage et des usagers de la route. Il est donc nécessaire de :

- S'assurer que l'équipage soit assis, ceinturé, face à la route avant de partir.
- Faire respecter une allure raisonnable au chauffeur : une vitesse trop élevée multiplie les risques d'accident, mais ne fera gagner que quelques secondes de trajet.
- Effectuer les passages d'intersection et les changements de voie en toute sécurité.
- Faire usage des avertisseurs sonores et lumineux à bon escient.
- Eviter au maximum (sans mise en danger) l'usage des avertisseurs sonores aux abords du CS

Rappel : Le chauffeur est maître du véhicule et engage son permis, il peut donc refuser une consigne du chef d'intervention allant à l'encontre du code de la route. Le chef d'intervention est responsable de l'équipage, il peut interdire au chauffeur tout comportement dont il juge qu'il met en danger la sécurité des bénévoles ou des usagers de la route. Une bonne communication en amont permet à chacun d'exposer ses habitudes et méthodes de travail privilégiées pour garantir une coordination efficiente lors des trajets.

Départ par radio

Si une intervention est affectée à un engin disponible mais qui est en dehors du CS (par exemple en retour d'hôpital), c'est le PVO du Centre de Secours qui se charge de transmettre le départ.

> *PVO : « Croix-Rouge française 901 Montmartre, ici le poste fixe de Montmartre, urgent, parlez. »*
>
> *CRF : « Poste fixe de Montmartre ici la Croix-Rouge française 901 Montmartre, transmettez. »*
>
> *PVO : « Croix-Rouge française 901 Montmartre, rendez-vous (telle adresse, compléments d'adresse) pour (tel motif), est-ce reçu, parlez. »*
>
> *CRF : « Poste fixe de Montmartre, la Croix-Rouge française 901 Montmartre qui se rend (telle adresse) pour (tel motif, compléments), est-ce correct, parlez. »*
>
> *PVO : « Correct, vous partez à (heure) ».*
>
> Le CI passe alors le statut 1 (parti) sur sa radio.

Si vous arrivez à afficher rapidement les détails de votre nouvelle intervention sur la tablette, vous pouvez aussi répondre directement en confirmant votre départ :

> *PVO : « Croix-Rouge française 901 Montmartre, ici le poste fixe de Montmartre, urgent, parlez. »*
>
> Le CI ouvre l'intervention sur sa tablette et confirme les informations de départ directement :
>
> *CRF : « Poste fixe de Montmartre ici la Croix-Rouge française 901 Montmartre, partie (telle adresse, compléments d'adresse) pour (tel motif), est-ce correct, parlez. »*
>
> *PVO : « Correct, vous partez à (heure) ».*
>
> Le CI passe alors le statut 1 (parti) sur sa radio.

Enfin, si vous vous situez à proximité immédiate du Centre de Secours (vous pouvez vous y rendre en moins de temps qu'il n'en faut pour prendre un départ par radio), vous pouvez le signaler afin d'interrompre la transmission :

PVO : « Croix-Rouge française 901 Montmartre, ici le poste fixe de Montmartre, urgent, parlez. »

CRF : « Poste fixe de Montmartre, la Croix-Rouge française 901 Montmartre se présente à son centre de secours. »

Le PVO interrompra sa transmission et se préparera à vous remettre l'ordre de départ à votre arrivée. Cette procédure est désormais peu utilisée depuis l'arrivée d'eFibi.

Difficultés à rejoindre l'intervention

Il peut arriver de rencontrer des difficultés à rejoindre les lieux de l'intervention dans le délai pour des motifs extérieurs non contrôlables : circulation bloquée, manifestation, petit train de Montmartre, etc. Il s'agit pour le CIR d'être proactif dans la détection de ces cas et de faire en sorte que les secours arrivent au plus tôt pour prendre en charge la victime.

CRF : « Golf 3, ici la Croix-Rouge française 321 Plaisance, parlez »

CSO : « Croix-Rouge française 321 Plaisance, ici Golf 3 parlez ».

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 Plaisance : faites partir un autre engin (telle adresse) pour (tel motif) ; Croix-Rouge française 321 Plaisance bloquée dans la circulation (telle adresse), Golf 3 parlez ».

Si toute une zone est difficile d'accès : « …bloquée dans la circulation (telle adresse), éviter secteur (place, lieu particulier, intersection, etc..), Golf 3 parlez »

CSO : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance : faites partir un autre engin (telle adresse) pour (tel motif) ; Croix-Rouge française 321 de Plaisance bloquée dans la circulation (telle adresse), message reçu à (telle heure) ».

CRF : « (telle heure), correct, terminé ».

Attention ! Malgré cela la mission est toujours en cours, et vous devez vous y rendre. Ce n'est qu'une fois sur place que les deux engins engagés sur l'intervention décideront de qui prend ou poursuit l'intervention, et qui se replacera disponible.

Non présenté au bout de 10 minutes

Lorsque le délai de 10 minutes sera dépassé, le PVO a pour consigne de contacter le chef d'agrès afin de s'enquérir de la situation. Il privilégiera, si possible, d'appeler sur le téléphone portable. Sinon, la procédure radio sera la suivante :

PVO : « Croix-Rouge française 101 de Chaligny, ici le poste fixe de Chaligny, parlez. »

CRF : « Poste fixe de Chaligny, ici la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, parlez. »

PVO : « Croix-Rouge française 101 de Chaligny, êtes-vous présentés sur les lieux de l'intervention, transmettez. »

CRF : « Poste fixe de Chaligny, la Croix-Rouge française 101 de Chaligny présentée il y a (X) minutes environ »

Ou

CRF : « Poste fixe de Chaligny, Croix-Rouge française 101 de Chaligny non présentée, bloquée dans la circulation (telle adresse), parlez. »

Présentation spontanée lors d'un trajet, équipage disponible

Si l'équipage est requis sur intervention durant un trajet où il est disponible, il se doit de répondre à la demande du requérant. Par conséquent l'équipage est en mission, non disponible, et le CSO doit en être informé.

Ainsi le CIR commencera par saisir le statut « 47 – Présentation spontanée » afin de se placer indisponible auprès du CSO. Il passera ensuite un message de présentation qui a pour but de donner au CSO le lieu et le motif de l'intervention.

CRF : « Golf 2 ici la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, parlez. »

CSO : « Croix-Rouge française 101 de Chaligny, ici Golf 2 parlez. »

CRF : « Golf 2, la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, présentation spontanée, (telle adresse) pour (tel motif), Golf 2 parlez ».

CSO : « Croix-Rouge française 101 de Chaligny, présentation spontanée (telle adresse) pour (tel motif), message reçu (telle heure). »

CRF : « Telle heure, correct terminé ».

Présentation spontanée durant un départ en intervention

Il peut arriver lors du trajet vers une intervention d'être requis pour une autre intervention (par des témoins, ou parce que l'on est témoin d'un événement). La conduite à tenir est la suivante :

- S'arrêter et s'enquérir de la situation
- Si nécessaire (victime requérant une prise en charge urgente), laisser sur place 2 secouristes (un PSE2 et un PSE1) avec le matériel minimum nécessaire pour procéder à la prise en charge initiale (collier cervical, oxygène…). Ne pas laisser le DSA.
- Dans tous les cas, le VPSP doit poursuivre sa mission initiale en expliquant aux témoins et à la victime que les secours arrivent : la demande de secours initiale doit impérativement être honorée.
- Le CIR passera rapidement le message suivant :

  CRF : « Golf 3 ici la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, parlez ».

  CSO : « Croix-Rouge 321 de Plaisance ici Golf 3, parlez ».

  CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, faites partir les secours (telle adresse), pour (tel motif), Croix-Rouge française 321 de Plaisance laisse 2 personnels sur les lieux et se dirige vers son intervention. Golf 3 parlez. »

  CSO : « Croix-Rouge française 321 de Plaisance, faites partir les secours (telle adresse), pour (tel motif), Croix-Rouge française 321 de Plaisance laisse 2 personnels sur les lieux et se dirige vers son intervention, message reçu (telle heure). »

  CRF : « Correct, terminé ».

La procédure vaut également pour les interventions incendie, mais sur lesquelles aucun équipier ne sera laissé sur place en l'absence de victime.

Équipage requis par un tiers alors qu'une intervention est en cours

Si l'équipage est requis sur une autre intervention par un tiers alors qu'il est déjà occupé à traiter son intervention initiale, il se doit de répondre à la demande du requérant.

Ainsi le CIR passera le message suivant, après avoir détaché le personnel et matériel requis pour initier la prise en charge :

> *CRF : « Golf 1 ici la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, parlez. »*
>
> *CSO : « Croix-Rouge française 901 de Montmartre, ici Golf 1 parlez. »*
>
> *CRF : « De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, faites partir les secours (telle adresse) pour (tel motif), Golf 1 parlez ».*

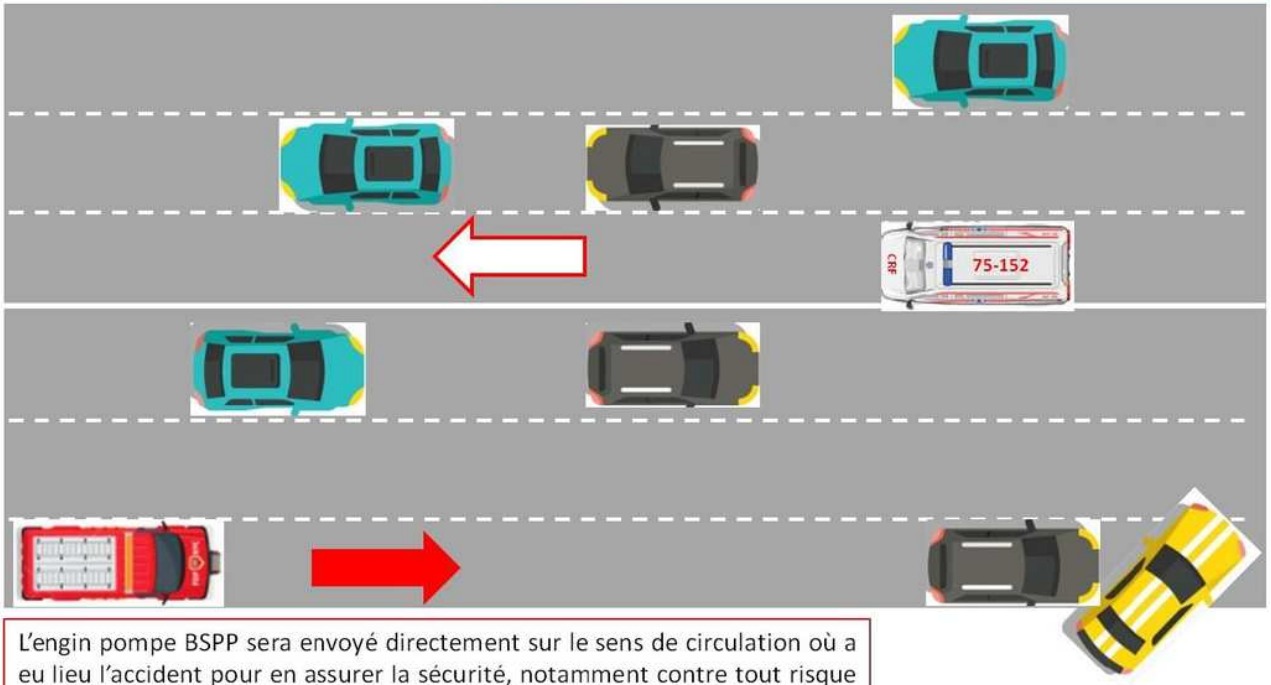
Il convient de préciser que même si vous êtes en intervention sur la voie publique et que l'on vous requiert pour une intervention sur le trottoir d'en face, il s'agit d'une autre intervention. Le message à passer est donc bien « faites partir » et non « je demande ».

Intervention sur voie rapide

En cas d'intervention **sur le périphérique ou l'autoroute**, deux engins seront sonnés (un engin de prompt secours, et un engin pompe). Ils auront sur leurs ordres de départ deux accès différents : un en amont de l'accident, un en aval. Chacun remonte le périphérique dans un sens, et le premier qui se présente sur l'intervention en informe le second. L'engin pompe est chargé d'assurer la sécurité de l'intervention, notamment en cas de risque d'incendie sur le ou les véhicules accidentés. Son gabarit en fait également un bouclier, à même de protéger les équipes de secours plus efficacement qu'un VPSP en cas de sur accident. Habituellement l'engin pompe recevra donc les informations lui permettant d'arriver sur les lieux en premier pour sécuriser les lieux et effectuer une reconnaissance avant l'arrivée de l'engin de prompt secours. Il peut cependant arriver que l'engin de prompt secours, soit le VPSP CRf, se présente sur les lieux en premier. Il est alors de la responsabilité du CIR BSPP d'assurer la sécurisation de l'intervention par un balisage efficace et une reconnaissance pour évaluer le nombre de victimes et les moyens à mettre en œuvre (au besoin demander en renfort) pour permettre leur prise en charge.

Contexte: AVP périphérique extérieur entre Porte de Châtillon et Porte d'Orléans impliquant deux véhicules de tourisme.

Le VPSP CRF sera envoyé sur l'autre sens de circulation par rapport à l'accident, pour ainsi passer devant et faire une première reconnaissance avant de se présenter dessus.
Accès par la Porte d'Orléans sur le périphérique intérieur puis sortie à Porte de Châtillon, pour faire demi-tour, prendre le périphérique extérieur à Porte de Châtillon et rouler vers le lieu de l'accident.



L'engin pompe BSPP sera envoyé directement sur le sens de circulation où a eu lieu l'accident pour en assurer la sécurité, notamment contre tout risque d'incendie des véhicules impliqués avant l'arrivée de la CRF.
Accès par la Porte de Châtillon sur le périphérique extérieur pour rouler directement vers le lieu de l'accident.

Lieu de l'accident

Il existe une procédure radio permettant de communiquer entre les deux engins dans cette situation. Toutefois, celle-ci est complexe et, dans la pratique, peu utilisée avec les associatifs. Il est donc recommandé d'échanger lors du départ les numéros de téléphone portable entre le CIR et le Chef d'Agrès de l'engin pompe ou de convenir de l'utilisation d'une fréquence tactique commune et de communiquer de la sorte.

Les messages de renseignement et demande de moyen sont passés par le COS, qui sera le chef d'agrès du premier engin sur les lieux. Ils suivent le cas général, en indiquant bien pour les demandes de moyen s'il s'agit du périphérique intérieur ou extérieur, ainsi que le point kilométrique pour permettre une localisation précise :

CRF : « De la Croix-Rouge française 611 d'Auteuil, je demande police, porte d'Auteuil, périphérique extérieur, point kilométrique 8,5 , pour un accident de la circulation impliquant 1 motocycliste et 1 véhicule de tourisme, 1 victime urgence relative, golf 3 parlez ».

En cas d'intervention sur autoroute, il existe certaines particularités :

- Il faut indiquer la borne kilométrique (ne pas confondre avec le point kilométrique, qui est l'unité de distance correspondant au périphérique) et le sens de circulation (Paris - Province ou Province - Paris) dans les messages de demande de moyen.
- La demande de Police doit être une demande de CRS.

Exemple de message :

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande compagnie républicaine de sécurité, autoroute A6 borne kilométrique 14 sens Paris -> Province, pour un accident de la circulation impliquant 1 motocycliste et 1 véhicule de tourisme, 1 victime urgence relative, golf 3 parlez ».

NB : dans les messages de demande de moyen, le CIR BSPP veillera à être précis dans les termes utilisés. Une « victime incarcérée » ne signifie pas la même chose qu'une « victime coincée » dans l'habitacle de son véhicule. En effet, le premier implique la nécessité de pratiquer une manœuvre de désincarcération pour accéder à la victime et donc une demande de renfort spécifique quand une « victime coincée » n'induit pas nécessairement de la découpe. Son extraction peut donc être assurée par l'engin pompe présent sur l'intervention par exemple.

Procédure ACR par message radio général

Depuis 2022, une nouvelle procédure permet de réduire les délais de prise en charge des ACR. Elle prend la forme d'un message radio passé par l'état-major :

> *« Urgent, urgent, urgent, ici l'État-Major silence radio. À tout engin disponible ou en transport hôpital à proximité de (telle adresse), rendez compte pour la prise en charge d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. Fin du silence radio. »*

Le chef d'intervention peut s'engager s'il s'estime proche de l'intervention et s'il est en déplacement sans victime à bord (en retour vers le CS par exemple).

L'équipage qui décide de s'engager répondra avec le message suivant :

> *« Golf 2, la Croix-Rouge française 101 de Chaligny se rend sur l'arrêt cardio-respiratoire (telle adresse). »*

Cette procédure permet également, depuis 2023, à un engin de s'engager sur l'ACR s'il est en cours de transport hôpital avec une victime UR à bord. L'équipage devra :

- retirer le Schiller DT7 de la victime transportée et l'éteindre (traçabilité des interventions)
- laisser un équipier en surveillance clinique de la victime
- se rendrez au contact de la victime en ACR et rallumer le Schiller DT7

La décision sur l'opportunité de s'engager dans un tel cas est du ressort du chef d'intervention. Il doit juger 1. qu'il n'y a pas de danger à retarder de quelques minutes son transport aux urgences, et 2. qu'il n'y a pas de danger pour le secouriste qui restera seul en surveillance.

PRÉSENTATION ET DÉROULEMENT DE L'INTERVENTION

NB : À partir de ce point, il est considéré que tous les messages sont précédés de la demande d'autorisation de transmission, sauf indication contraire :

CRF : « Golf X, ici la Croix-Rouge française XXX de (centre de secours), parlez »

CSO : Croix-Rouge française XXX de (centre de secours), ici Golf X parlez »

Cela ne sera donc pas répété dans les chapitres suivants.

Présentation sur un autre secteur / groupement

En situation nominale, le CIR passe simplement le statut « 2 – présentation » lorsqu'il se présente sur un autre secteur.

Dans le cas où les statuts dysfonctionnent et que les messages de déplacements doivent être passés en phonie, la procédure est la suivante : on précise le secteur dans lequel on se présente.

CRF : « Golf 3, la Croix-Rouge française 321 de Plaisance se présente secteur Montrouge».

PVO : « Poste fixe de Montrouge reçu ».

Le CIR réitérera son message jusqu'à obtenir une réponse du poste fixe du secteur sur lequel il intervient.

NB : Il n'y a pas de demande d'autorisation d'émettre à faire lorsqu'il s'agit d'un message de présentation, même en cas d'intervention sur un secteur autre que celui du CS d'affectation.

Cas particulier : si l'intervention se situe sur un autre groupement, il faudra changer de canal (via les boutons sur le côté de la radio) et passer sur le SGAP OPS du groupement où se situe l'intervention. Par exemple :

Vous êtes de garde au CS Chaligny (G2). Vous êtes sonné et l'ordre de départ indique « CSTC : Charonne », donc dans le G1. Après avoir renseigné le statut parti sur le SGAP OPS 2, vous basculerez sur la fréquence SGAP OPS 1 et ce jusqu'au moment de renseigner le statut « 25 – Quitte l'hôpital ». Cela vous permettra de joindre et d'être joint en cas de besoin par le CSO du G1, qui est votre autorité tout le temps de l'intervention sur son secteur.

Demande de confirmation d'appel et d'adresse

La demande de confirmation d'appel et d'adresse intervient après le statut ou le message de présentation. L'équipage s'est présenté à l'adresse de l'intervention mais, après reconnaissance, ne trouve pas de victime ou ne peut pas accéder au lieu. Il est interdit de rappeler directement le requérant soi-même.

La demande doit être faite immédiatement par statut et par phonie. Les blocs horaires des statuts et messages sont enregistrés et conservés par la BSPP. En cas de litige, ce sont eux qui seront utilisés pour constater de la rapidité d'intervention des secours. Cette demande est à passer même si l'accès à la victime est possible mais cependant compliqué au point de nécessiter du temps ou que la victime s'est déplacée par rapport à l'adresse d'intervention inscrite sur l'ordre de départ. Il s'agit encore une fois de s'assurer de pouvoir justifier de l'action de secours mise en place.

Le déroulé est donc le suivant :

Le CIR renseigne le statut 41 sur son poste radio.

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande confirmation d'appel et d'adresse (motif) (telle adresse), Golf 3 parlez. » Une précision peut être ajoutée à la demande, par exemple : *« Le code d'entrée est incorrect »* ou *« le nom n'existe pas sur l'interphone ».*

CSO : « Croix-Rouge française 321 de Plaisance, vous demandez confirmation d'appel et d'adresse (motif) (telle adresse), message reçu à (heure). Poste fixe reçu ? »

PVO : « Poste fixe de Plaisance reçu ».

Le stationnaire tente alors de contacter le requérant, puis le CO, pour obtenir plus d'informations. S'il en obtient, il contacte l'engin et donne les nouvelles consignes :

PVO : « Croix-Rouge française 321 de Plaisance, le code d'entrée est le 6150B, est-ce reçu parlez ».

CRF : « Le code d'entrée est le 6150B, est-ce correct parlez ».

PVO : « Correct, terminé ».

Important : Une fois parvenu sur les lieux, le CIR BSPP devra repasser un statut de présentation (statut 2) sur les lieux de l'intervention.

S'il n'a pas été possible d'obtenir plus d'informations, le PVO contacte l'engin et passe le message suivant :

PVO : « Croix-Rouge française 321 de Plaisance, après confirmation d'appel et d'adresse auprès du CO : aucune information complémentaire. Est-ce reçu, parlez ».

CRF : « Aucun renseignement complémentaire, message reçu ».

L'intervention est alors terminée. Le CIR se replace alors disponible s'il est sur son secteur, ou roule vers son secteur.

Intervention déjà prise en charge

Dans le cas où l'intervention est déjà traitée par un autre engin (intervention en doublon par exemple), et dans le cas où l'autre engin poursuit seul la prise en charge, le CIR passe le message suivant :

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, il s'agit de la même intervention que le (indicatif complet de l'engin, par ex : Véhicule de Secours à Victimes 132 de Plaisance), parti (tel motif, telle adresse). »

CSO : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, il s'agit de la même intervention que le (indicatif complet de l'engin), parti (tel motif, telle adresse), message reçu (telle heure). »

CRF : « (Telle heure), correct terminé ».

S'il est sur son secteur, le CIR se placera ensuite disponible avec le statut adéquat, ou la phonie si nécessaire.

Intervention à plusieurs engins

Il est possible d'être sonné à plusieurs engins pour une même intervention, soit en raison d'un doublon d'appel, soit parce que plusieurs moyens sont nécessaires. Il y a un principe simple à retenir :

Premier engin sur place = Premier COS

Le fait d'être un associatif ne change pas cette règle : tant qu'un chef d'agrès de la BSPP n'a pas passé de message de reprise de commandement, vous demeurez le COS sur l'intervention si vous vous êtes présenté en premier.

Cela n'empêche pas de savoir se faire conseiller et être à sa bonne place !

Intervention médicalisée

Si après contact de la coordination médicale une équipe médicale est déclenchée, il est nécessaire de transmettre un message de renseignement. Cela n'est pas nécessaire si l'équipe médicale est déjà au départ des secours.

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, secours à un(e) homme/femme malade/blessé(e), urgence absolue, telle adresse, tel étage / VP, et attendons équipe médicale, Golf3 parlez ».*

Puis, pour présenter une UMH (on ne présente pas une AR puisqu'il s'agit d'un moyen BSPP et qu'elle fera sa propre présentation), plusieurs options sont possibles :

« De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, … »

Situation	**Message**
L'UMH est sur place à votre arrivée et vous n'attendez pas d'autres moyens : message dès votre arrivée	*« … secours à un homme malade, urgence absolue, telle adresse, tel étage / VP, équipe médicale Necker présentée avant notre arrivée, Golf 3 parlez »*
L'UMH se présente et vous n'attendez pas d'autres moyens, vous n'avez pas encore passé de message de renseignement : message dès l'arrivée de l'UMH	*« … secours à un homme malade, urgence absolue, telle adresse, tel étage / VP, équipe médicale Necker se présente, Golf 3 parlez »*
L'UMH se présente et vous n'attendez pas d'autres moyens, vous avez déjà passé un message de renseignement : message dès l'arrivée de l'UMH	*« … équipe médicale Necker se présente, Golf 3 parlez »*
Plusieurs moyens sur l'intervention (ou bien vous avez oublié de passer le message de présentation), vous assurez l'évacuation : message en fin d'intervention	*« … équipe médicale Necker présentée à telle heure, Golf 3 parlez »* + Dans le G2, on ajoute : *« … et assurons transport »*. + Dans tous les cas, si le transport est médicalisé, il faut aussi le mentionner.
Plusieurs moyens sur l'intervention (ou bien vous avez oublié de passer le message de présentation), l'UMH assure l'évacuation : message en fin d'intervention	*« … victime évacuée par l'équipe médicale Necker présentée à telle heure, Golf 3 parlez »*

Dans la mesure du possible, on précise toujours la nature de l'urgence absolue : secours à une femme blessée, secours à un homme dans le coma, secours à une femme en arrêt cardio-respiratoire, secours à un homme en UA blessé par arme blanche, etc.

Accident de circulation

À noter : on utilise souvent à la Croix-Rouge le terme d'AVP (accident de la voie publique) mais dans les procédures radios BSPP, le terme correct sera « accident de circulation ».

Un accident de circulation implique nécessairement un message de renseignement (et probablement demande de moyen), et un message de clôture de l'intervention, sauf dans le cas particulier où aucun moyen

complémentaire ne s'est présenté et que vous prenez en charge l'évacuation. Le tableau suivant détaille toutes les possibilités :

Message de renseignement / demande de moyens		**Message de clôture**
De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande…	Police Compagnie républicaine de sécurité X Engins de prompt secours X Engin(s) pompe(s) X Camion(s) de désincarcération	De la Croix-Rouge française de Plaisance, …. présenté à telle heure,
Telle adresse / borne kilométrique, accident de la circulation impliquant…	X cyclomotoriste(s), X véhicule(s) de tourisme, X véhicule(s) électrique(s), X véhicule(s) hybride(s), X poids lourds, X cycliste(s), X piéton(s), Un tramway, Un véhicule de transport en commun,	
Seul / Et :	X cyclomotoriste(s),, X véhicule(s) de tourisme, X poids lourds, X cycliste(s), X piéton(s), …	
Dénombrement terrain provisoire : *(si le bilan est certain, le donner sans la mention « dénombrement terrain provisoire »)*	X victimes décédées, X victimes urgence absolue, X victimes urgence relative	Dénombrement terrain définitif : … laissée(s) à disposition de la Police, … évacuée(s) par équipe médicale XXX, … évacuée(s) par moyen de transport non médicalisé *(si pas « dénombrement terrain provisoire », ne pas dire « dénombrement terrain définitif »)*
(si nécessaire) Circulation interrompue sur :	X voies Nom de la voie de circulation *NB : le numéro des voies de circulation sur voie rapide se compte toujours à partir de celle qui se trouve le plus à gauche. Ainsi sur un tronçon à quatre voies, la deuxième voie en partant de la droite est en fait la troisième voie.*	Rétablissement de la circulation laissé à disposition de la Police
(si équipe médicale en route)		Équipe médicale *(nom de l'hôpital)*

Et attendons équipe médicale		présentée à *(telle heure)*
Golf 2 parlez.		Golf 2 parlez.

Remarques concernant la typologie des véhicules :

- Bus = « véhicule de transport en commun »
- Une voiture électrique est « un véhicule électrique », c'est une catégorie à part
- Une voiture hybride est « un véhicule hybride », c'est une catégorie à part

En cas de doute sur le message à passer pour obtenir des moyens supplémentaires, il sera toujours possible d'utiliser un message "joker" (ne pas en abuser cependant et à réserver aux situations les plus complexes). Il s'agira de demander un « complément de départ » et de décrire ensuite le plus précisément mais succinctement possible l'évènement :

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande le complément de départ pour (motif le plus précis possible), Golf 3 parlez. »*

En fonction du motif indiqué, le CSO vous enverra les moyens qu'il juge nécessaires en tenant compte de la disponibilité des engins. Il est probable que soit envoyé un engin pompe avec un chef d'agrès expérimenté pour proposer une aide au commandement voire reprendre le commandement des opérations de secours sur place.

Intervention sur un mineur

Dans le cas de la prise en charge d'un mineur non émancipé, non accompagné par un représentant légal (parent ou tuteur), la présence de la police n'est pas nécessaire pour procéder au transport en milieu hospitalier. Le chef d'intervention doit en revanche essayer obtenir l'accord des parents/tuteurs avant de procéder à l'évacuation, sauf urgence vitale. S'il ne parvient pas à obtenir cet accord, il demandera par téléphone au PVO de prévenir le commissariat du transport d'un mineur en milieu hospitalier.

Dans le cas d'une prise en charge en établissement scolaire, il sera demandé si possible une copie de l'autorisation parentale autorisant la prise en charge médicale, dont l'établissement dispose normalement. Le transport d'un mineur vers une structure hospitalière est alors signalé à la police par le PVO à la demande du CIR. Le rapport ADAGIO doit comporter mention de cet appel.

Dans le cas d'un mineur accompagné de ses parents, qui refusent la prise en charge demandée par la coordination médicale, une demande de Police doit être réalisée :

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, je demande Police pour un mineur dont les parents refusent la prise en charge, Golf 1 parlez »*

La police doit également être demandée dans le cas d'un mineur ayant échappé à la surveillance des secours (fuite d'un mineur).

Dans tous les cas, les coordonnées des parents ou du tuteur doivent être remises à l'hôpital.

Pour rappel : un mineur de moins de 16 ans doit être transporté vers un service d'urgences pédiatrique, entre 16 et 18 ans dans un service pour adultes.

Accident de travail

Lorsque l'équipage intervient sur une personne blessée sur son lieu de travail, il est nécessaire de demander la police. Il faut pour cela que la situation soit suffisamment grave : décès, blessure grave (mettant en jeu la vie ou

la qualité de vie), ou autre situation à risque ou de maltraitance pour laquelle le CIR juge que l'intervention de la Police est nécessaire.

CRF : « De la Croix-Rouge français 101 de Chaligny, je demande Police, (telle adresse), pour un accident de travail, Golf 2 parlez ».

Arrêt Cardio-Respiratoire

Dans le cas où l'équipe intervient sur un arrêt cardio-respiratoire, le CIR doit faire un message de renseignement. Il peut le coupler avec la présentation de l'engin si c'est une UMH et qu'elle est déjà arrivée (on ne présente pas une AR BSPP).

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, secours à un(e) homme/femme en arrêt cardio-respiratoire telle adresse, tel étage / VP, et attendons équipe médicale, Golf3 parlez ».*
>
> ou
>
> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, secours à un(e) homme/femme en arrêt cardio-respiratoire telle adresse, tel étage / VP, équipe médicale Necker se présente / police se présente, Golf3 parlez ».*
>
> ou
>
> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, secours à un(e) homme/femme en arrêt cardio-respiratoire, telle adresse, tel étage / VP, équipe médicale Necker présentée avant notre arrivée / police sur les lieux, Golf3 parlez ».*

Si l'équipage CRf est le seul moyen de prompt secours engagé sur l'intervention, il devra demander un engin de prompt secours pour renfort massage.

Enfin, dans le cas où l'ACR intervient sur la voie publique, le CIR devra demander la police sur les lieux de l'intervention : pour le maintien de l'ordre public, pour assurer le respect de la dignité de la victime et pour la prise en charge du corps si la victime est laissée sur place, décédée. Il peut aussi demander un écran brise-vue, si nécessaire.

Cas particulier : en cas de pendaison, le message est le suivant :

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande police, secours à un(e) homme/femme pendu(e) en arrêt cardio-respiratoire, telle adresse, tel étage / VP, et attendons équipe médicale, Golf3 parlez »*

Victime décédée

Il existe deux cas de figure, la découverte d'un décès certain et une victime qui décède au cours de l'intervention.

Dans le cas de la **découverte d'un décès certain**, le CIR passera le message suivant :

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande Police telle adresse, tel étage / VP, découverte d'une victime décès certain, Golf 3 parlez ».*

Le CIR s'assurera que la scène de l'intervention subisse le minimum de dégradation possible dans le cas où les circonstances du décès seraient suspectes (possibilité d'ouverture d'une enquête judiciaire). Une fois la Police sur les lieux, elle pourra demander un Officier de Police judiciaire si besoin. L'OPJ doit être présenté dans un message de renseignement, lors de sa présentation ou bien lors du message de fin d'intervention :

> *CRF : « De La Croix-Rouge française 321 de Plaisance, officier de police judiciaire se présente »*

ou

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, Police présentée à (telle heure), officier de police judiciaire présenté à (telle heure), Golf 3 parlez ».

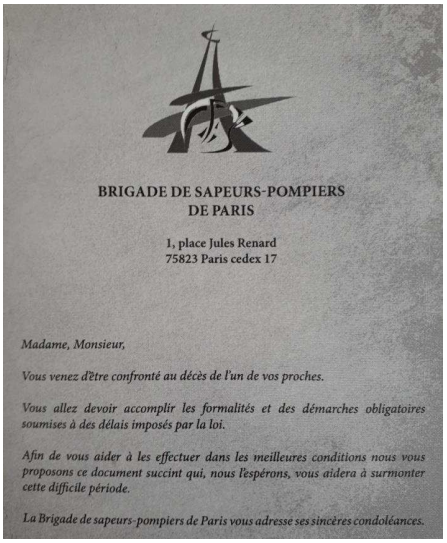
Il n'y a pas lieu de remplir une fiche ACR puisqu'il n'y a pas eu de réanimation. Il est toutefois impératif de remplir une fiche bilan avec l'identité de la victime et les informations disponibles selon les circonstances.

Rappel : les cas de décès certain sont : rigidité cadavérique, putréfaction, tête séparée du tronc, éclatement de la boîte crânienne et destruction évidente du cerveau.

Dans le cas d'une **victime déclarée décédée par le moyen médical lors de l'intervention**, le CIR aura déjà passé un message de renseignement. Il devra donc clôturer son intervention par un message expliquant le devenir de la victime.

CRF : « De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, victime décédée laissée sur place à disposition de la famille / de la Police, Golf 3 parlez »

En cas de décès de la victime au cours de l'intervention, la BSPP a publié un fascicule qui permet de présenter ses condoléances à la famille et résume les démarches administratives qui seront à effectuer. Il s'agit d'un outil fort utile et disponible dans les centres de secours.



BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS
DE PARIS

1, place Jules Renard
75823 Paris cedex 17

Madame, Monsieur,

Vous venez d'être confronté au décès de l'un de vos proches.

Vous allez devoir accomplir les formalités et des démarches obligatoires soumises à des délais imposés par la loi.

Afin de vous aider à les effectuer dans les meilleures conditions nous vous proposons ce document succint qui, nous l'espérons, vous aidera à surmonter cette difficile période.

La Brigade de sapeurs-pompiers de Paris vous adresse ses sincères condoléances.

Cas particulier de l'obstacle médico-légal : si la cause de la mort ne peut pas être déterminée par le médecin ou prête à interrogation (circonstances, absence d'antécédents ou autres), celui-ci peut déclarer un obstacle médico-légal. Dans ce cas, il complétera un rapport qui sera déposé dans une enveloppe scellée à remettre à la Police. Si cette dernière n'est pas déjà présente sur les lieux, il conviendra d'en faire la demande et de présenter l'officier de police judiciaire à son arrivée. Le CIR BSPP pourra être amené à fournir son témoignage quant au déroulement de l'intervention et à laisser ses coordonnées pour être recontacté en cas de questions ultérieures.

Si l'ONYX n'est pas présent sur les lieux à ce stade, il convient de lui demander de se déplacer.

La déclaration d'un obstacle médico-légal équivaut à l'ouverture d'une procédure d'enquête pour mort suspecte. La victime sera autopsiée et les conclusions du médecin légiste détermineront la suite qui sera donnée à la procédure (clôture ou poursuite des investigations).

BILAN, CONTACT ET FIN D'INTERVENTION

Rédaction de la fiche bilan

La fiche bilan est à la fois le fil conducteur et la trace de votre intervention. La renseigner correctement permet de s'assurer que vous n'avez pas oublié d'élément important, facilitera la prise en charge par les services hospitaliers, et constitue une preuve de votre travail en cas de litige ou enquête ultérieurs. Elle est désormais rédigée sur tablette via l'application eFibi.

Les points-clés de la rédaction de la fiche bilan eFibi :

- L'identité complète de la victime est renseignée, ses coordonnées, et les coordonnées d'une éventuelle personne à prévenir en précisant son lien de parenté/filiation avec la victime.
- Un motif de recours aux secours doit être sélectionné (vous pouvez en choisir plusieurs). Sans cela, le bilan ne sera pas complet car certains onglets ne vous seront pas présentés.
- L'onglet « synthèse » vous permet d'avoir une vue globale sur votre bilan et l'intervention.

En cas de défaillance eFibi (et uniquement dans ce cas), il est possible de rédiger une fiche bilan papier, que vous devez avoir dans votre administratif en prévision. Les points importants :

- Une écriture lisible, au stylo bille noir
- L'en-tête doit être renseigné : la date et l'heure sont normalement la date et l'heure de présentation, non de départ.
- Une case rouge cochée = contact obligatoire (pour les moyens BSPP ; pour la CRf, contact obligatoire dès lors que prise en charge d'une victime)
- Le bloc lieu d'intervention est correctement renseigné ; les « ronds » sont entourés ;
- « Détails des circonstances ayant motivé l'appel » : un bilan primaire type réseau alpha correspond bien à cette partie (sexe, âge, position à l'arrivée, avec ou sans détresse vitale, plainte principale et contexte de survenue) ;
- Bilan primaire : cocher les cases concernées (le champ « FOM » n'est plus en vigueur)
- Plainte exprimée et signes spécifiques : description des signes de détresse, plaintes, PQRST
- Bilans neurologique, respiratoire, circulatoire : cocher les cases appropriées, barrer les signes recherchés et non présents en lien avec la plainte/détresse pour prouver qu'ils ont effectivement été recherchés;
- Bilan lésionnel, éléments divers, gestes : renseigner les éléments correctement
- Surveillance : renseigner obligatoirement la case aggravation oui/non ; dans tous les cas, remplir le tableau de surveillance avec au moins les constantes à l'arrivée à l'hôpital
- Contact coordination : ne pas oublier d'indiquer l'heure de contact ainsi que la suite donnée (évacuation/par quel moyen/vers quel hôpital et service ou LSP avec ou sans décharge)
- Pour la signature : « CRF – Nom de famille – Nivol – Signature »

En cas de défaillance eFibi sur intervention, ou tout autre cas d'empêchement d'utilisation de la tablette, le problème devra être remonté avec un rapport détaillé par mail (demandez conseil pour savoir à qui l'adresser et comment le rédiger). De plus, le bilan doit être régularisé sur eFibi, en incluant une photo de la fiche bilan papier.

Coordination médicale

La BSPP dispose de sa propre régulation médicale qui reçoit les bilans de ses équipes, et se coordonne au besoin avec la régulation médicale du SAMU (qui reste l'autorité médicale du département). Le chef d'intervention contacte la coordination pour leur transmettre son bilan. Il peut le faire :

- Par téléphone sur le **numéro « non urgent »** (01 58 57 51 02) pour une victime sans détresse vitale
- Par téléphone sur le **numéro « urgent »** (01 58 57 51 00) dans trois cas :

    - une demande de moyen médical pour une victime avec détresse vitale
    - toute intervention pour laquelle le CIR a un doute, ou besoin d'un conseil médical
- Par téléphone sur le **numéro « UNV »** (01 58 57 51 18) en cas de suspicion d'AVC, dans le cadre d'une procédure UNV (orientation rapide vers une unité neuro-vasculaire). Le bilan doit être très complet afin de faciliter la recherche de place et les échanges avec les neurologues de garde.
- Par téléphone sur le **numéro « ECG »** (01 58 57 51 15) si un ECG a été réalisé
- Par radio sur la fréquence « SGAP COORD » dans l'incapacité de contacter la coordination par téléphone (cas exceptionnel). Sur cette fréquence, il n'y a pas de formalisme particulier sur les messages, hormis les règles élémentaires à respecter dans le cadre de transmissions radios.

Victime laissée sur place

Pour laisser une victime sur place, l'accord de la coordination médicale est indispensable (les cas de LSP sans contact pour les équipages BSPP ne s'appliquent pas aux AASC). Il s'agit soit d'un cas où le transport n'est pas jugé nécessaire par la coordination, soit d'une victime qui refuse le transport proposé et pour laquelle la coordination médicale finit par accepter un laisser sur place.

Dans ce cas, une fiche décharge BSPP doit être remplie en 2 exemplaires, après avoir été lue et expliquée à la victime. Les témoins remplissant les cases dédiées sur la fiche ne peuvent être des membres de l'équipage Croix-Rouge (sauf si l'absence de témoins ne permet pas de faire appel à quelqu'un d'autre). Un exemplaire de la fiche est laissé à la victime.

La décharge est ensuite prise en photo et attachée à la fiche d'intervention eFibi. En cas de défaillance eFibi, le second exemplaire de la décharge est collé au dos de la fiche d'intervention. La notion de décharge doit être indiquée dans le message de rentrée ainsi que dans le rapport ADAGIO.

Police demandée non présentée

Suite à une demande Police, le Chef d'Intervention attendra 15 minutes. Si la Police n'est pas présentée, il passera le message suivant :

> *« De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je redemande Police, Golf 3 parlez ».*

Après une nouvelle attente de 20 minutes, et si la police n'est toujours pas présentée, l'équipage peut se désengager pour procéder à l'évacuation de la victime. Le CIR BSPP passera alors le message suivant :

> *« De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, police demandée à (telle heure) non présentée, Golf 3 parlez »*

L'évacuation se poursuit ensuite normalement.

Cette procédure n'est applicable qu'en cas d'évacuation de la victime. Il n'est par exemple pas possible de se désengager sans présentation de la Police sur un décès certain.

Demande d'une escorte motorisée

Le besoin d'une escorte motorisée est exprimé par l'équipe médicale (UMH ou AR) qui juge cette escorte nécessaire au regard de la priorité d'évacuation de la victime. Charge au COS, donc potentiellement le CIR BSPP, de mettre en œuvre cette demande. Deux cas de figure se présentent alors.

Si la Police est déjà présente sur les lieux de l'intervention, la demande de l'escorte motorisée leur sera directement adressée. Le CIR intégrera alors cette information dans son prochain message de renseignement, ou un message dédiée (s'il ne prévoit pas de nouveau message de renseignement avant l'arrivée de l'escorte) :

CRF : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, secours à un homme malade, et attendons escorte motorisée, Golf 2 parlez ».

Dans le cas où la police n'est pas présente sur les lieux de l'intervention, le CIR demandera l'escorte motorisée par un message radio :

CRF : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande une escorte motorisée, (telle adresse), pour transport d'une victime vers l'hôpital (nom de l'hôpital), précisez un délai. Golf 2 Parlez ».

CSO : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande une escorte motorisée, (telle adresse), pour transport d'une victime vers l'hôpital (nom de l'hôpital), message reçu à (telle heure) »

CRF : « (Telle heure), correct et attendons ».

La demande de délai permet au médecin de décider de l'intérêt d'attendre ou non l'arrivée de l'escorte.

NB : Le CSO vous demandera presque systématiquement de le contacter par téléphone suite à cette demande. N'ayez pas d'inquiétude, il s'agit d'une procédure courante pour demander plus d'informations, et communiquer le délai estimé.

Évacuation et inscription à l'hôpital

Lorsque la décision d'évacuation a été prise (par la coordination médicale,), le CIR BSPP s'assure :

- D'avoir les papiers d'identité de la victime et sa carte vitale, si possible
- D'avoir un accompagnant (obligatoirement majeur) au maximum, assis ceinturé
- En cas d'intervention à domicile, que la sécurité soit assurée : pas d'enfants laissés sans surveillance, que la victime ait ses clés, pas de gazinière ou four allumé, etc.

L'évacuation ne se fait avec avertisseurs sonores que sur demande de la coordination médicale. Les procédures radios concernant l'évacuation et la présentation à l'hôpital sont les suivantes :

Étape de l'intervention	**Statut**	**Message en phonie (en mode dégradé)**
Transport hôpital	5	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) se dirige vers l'hôpital (nom de l'hôpital) »*
Se présente à l'hôpital	6	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) se présente à l'hôpital (nom de l'hôpital) »*
Quitte l'hôpital	25	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) quitte l'hôpital (nom de l'hôpital) »*
Disponible	7	*« Golf X, la Croix-Rouge française XXX de (Centre de secours) est disponible » — « Poste fixe de (Centre de secours) reçu »*
Rentré	9	Saisi directement par le PVO

Points d'attention :

- Le CI crée un « code de partage » sur eFibi pour l'inscription administrative.
- Il procède à l'inscription administrative, puis à la transmission IAO (ou l'inverse selon les hôpitaux). Dans tous les cas, il doit cliquer dans eFibi « Transmission du patient » et faire signer l'IAO sur la tablette.
- En cas de fiche bilan papier, il doit inscrire dessus indique l'heure de présentation à l'hôpital, faire signer la fiche par l'IAO (dans l'encadré en bas à droite). L'exemplaire original est remis à l'IAO, la copie carbonée conservée pour être remise au CS.

- Le retour au statut disponible se fait une fois sorti de l'enceinte de l'hôpital (si secteur), juste après avoir envoyé le statut 25 « Quitte l'hôpital ». Cela évite le risque de recevoir un départ et d'être bloqué à l'intérieur de l'hôpital (barrière qui tomberait en panne, sortie bloquée par un véhicule, etc).

Délai d'attente à l'hôpital supérieur à 30 minutes

Dans le cas où l'attente à l'hôpital pour la transmission à l'IAO dépasse les 30 minutes, le CIR peut contacter à nouveau la coordination médicale afin de solliciter l'autorisation de laisser la victime sans l'avoir transmise à l'IAO. Seule la coordination médicale peut donner cette autorisation. Cela devra être précisé par le CIR dans son message de rentrée.

ATTENTION : il s'agit d'une procédure très exceptionnelle, rarement utilisée par les chefs d'agrès BSPP eux-mêmes. Son emploi par un équipage CRf est donc tout sauf recommandé (conséquences lourdes en termes d'image). Cette procédure ne figure dans le présent référentiel qu'à titre informatif, et ne devra être employée qu'à la demande de la BSPP ou de l'Onyx.

Message de rentrée et compte rendu d'intervention

Le message de rentrée est communiqué au PVO dès le retour d'intervention, après avoir remis la radio en charge. Ce message comporte neuf points au total. Pour un moyen associatif, les points 1 et 5 sont systématiquement remplis ; le point 2 si une victime est prise en charge ; les points 3, 6 et 7 peuvent parfois être utilisés.

Le chef d'intervention les énumérera de la façon suivante, dans l'ordre et en indiquant le chiffre :

1 – Actions menées par l'équipage

Bilan ou Recherche

Matériel / technique utilisé : DSA, MCE (massage cardiaque externe), RCP, Aspiration, Insufflation, Oxygénothérapie, ECG, Immobilisation Générale, Attelle, Relevage

Contact coordination : médecin ou opérateur

Décharge

2 – Victimes

Pour chaque victime : Nom, prénom, âge, sexe, nationalité (si étrangère), SDF le cas échéant, UA/UR/DCD (victime UA = évacuée par équipe médicale ou évacuée médicalisée dans le VPSP)

Vecteur de transport et hôpital d'évacuation (et service, si différent des urgences générales) ; ou LSP

Si militaire (dont gendarmes) ou policier : préciser grade, matricule, corps d'appartenance, affectation et fonction.

3 – Moyens de secours privés utilisés

Dans notre cas, ne concerne que l'usage d'un défibrillateur public.

5 – Description des dégâts provoqués par les secours.

Vêtement découpé (si valeur marchande importante, par exemple tenue de motard), vitre cassée, etc.

Si rien : dire « néant ».

6 – Difficultés particulières rencontrées.

Retard dans la présentation des secours dû à une circulation dense, Véhicule immatriculé XXXXX a refusé de céder la priorité aux secours, Refus de l'IAO de signer la fiche d'intervention, différend avec le médecin de l'UMH, etc.

7 – Nécessité de prévenir des services particuliers

EDF, GDF, ou autres. SI besoin d'y recourir, prendre conseil au préalable auprès du sergent de jour.

Le message de rentrée se termine par la mention d'un **CRI (Code Retour Intervention)**. Les plus courants sont :

310 Intoxication	356 Chute
320 Maladie	399 Autre intervention de secours à victime
343 Relevage de personne impotente	*2xx Secours routier sans désincarcération*

Une liste plus exhaustive des CRI est donnée en annexe, et la liste complète est disponible au PVO. Des exemples de messages de rentrée sont donnés en annexe de ce document.

NB : Les pratiques divergent entre les groupements sur l'ordre et le contenu du message de rentrée. De plus, elles évoluent régulièrement. N'hésitez pas à demander les consignes au PVO en début de vacation si vous n'êtes pas habitué du centre de secours.

Rapport d'intervention ADAGIO

Le rapport d'intervention ADAGIO constitue, avec la fiche bilan, la trace juridique de l'intervention ; il doit être rempli de façon détaillée et rigoureuse. Il permet également la réalisation de statistiques par la BSPP. Sa saisie se fait de la façon suivante, dans le cas où vous êtes l'engin principal :

- Si besoin, lancez l'application « GDR » (Gestion Des Rapports)
- Dans la liste des interventions, double-cliquez sur la vôtre
- Saisissez les identifiants : code 4 lettres du CS (par exemple : PLAI), mot de passe : pompiers
- Le récapitulatif de l'intervention s'affiche à droite. Cliquez sur le bouton « Création » en bas à droite.
- Dans la partie supérieure de l'écran, vous pouvez signaler une intervention nécessitant un regard particulier (présence d'une autorité, médiatisation, risque important de judiciarisation…).
- Dans le bloc « Adresse », vous pouvez modifier l'adresse de l'intervention si incorrecte
- Renseignez obligatoirement :
- L'étage (ou VP)
- Le code CRI (s'il est absent, il faut s'assurer auprès du stationnaire que l'intervention a été clôturée)
- Le code localisation (clic droit dans la zone pour afficher la liste)
- Sauvetages / mise en sécurité : ne concerne que les interventions incendie
- Contact autorité : à renseigner si vous avez contacté une autorité BSPP particulière en cours d'intervention. Vous devez y ajouter « Opérateur coordination », « Infirmier coordination » ou « Médecin coordination » pour informer du niveau de votre interlocuteur à la coordination lors de votre contact pour bilan (la pratique peut varier selon les groupements).
- Contact service : sera normalement renseigné par le CSO ou le PVO (demande de Police, etc.)
- Vérifiez à droite les questions posées et cochées celles concernées par votre intervention.
- Sur l'écran suivant, si vous n'avez causé aucun dégât, découpé aucun vêtement, cliquez sur « Néant » et passez à l'écran suivant. Sinon indiquez succinctement les dégâts occasionnés, par exemple: "Divers vêtements découpés".
- Commencez par renseigner la partie supérieure de l'écran :
- Utilisation spécifique : détecteur CO s'il a été déclenché, DAE si vous l'avez utilisé
- Utilisation générale : concours inutile si intervention prise en charge par un autre moyen et ne nécessitant pas de renfort de votre part, personnel seul si pas de victime trouvée, personnel et matériel si victime laissée sur place, transport si victime transportée à l'hôpital par vos soins.

- Ensuite, l'onglet « personnels » : renseigner l'identité du CIR BSPP, et de l'intégralité de l'équipage (elle est conservée par la suite ; à vérifier cependant à chaque rapport).
- Statuts : vérifiez la cohérence des statuts et des horaires ; si besoin d'en ajouter, utilisez le clic droit. De la même manière, reportez dans le bloc « Messages » les heures de vos messages figurant dans la liste (demande de moyens, messages de renseignement…)
- **Depuis septembre 2025, il ne faut plus « Ajouter une victime ». Les données déjà saisies dans eFibi font foi.**
- Passer à l'étape suivante ; un récapitulatif est affiché avec les éventuelles erreurs sur votre rapport. Il est normal que soient affichés :
    - « Intervention de plus de 45mn »
    - Pas de numéro SINUS pour telle victime
    - Pas de numéro FOM pour telle victime
- Les autres messages d'erreurs doivent être traités et corrigés dans votre rapport. Ils apparaissent en rouge quand les messages non bloquants (listés ci-dessus), apparaissent avec une icône bleue.
- Cliquez sur « Sélectionner le COS », choisissez votre nom et double-cliquez dessus.
- Votre rapport sera validé si vous êtes le seul engin sur l'intervention (coche verte dans la liste des « Rapports effectués). Sinon, il ne sera validé que lorsque tous les engins auront validé leurs rapports.
- Vérifiez avant la fin de la garde que tous vos rapports sont validés, sous peine de devoir revenir le lendemain…

NB : Si vous devez rédiger un rapport secondaire (participation à une intervention dont vous n'êtes pas le COS), demandez conseil afin de ne pas perturber le rapport de l'engin principal.

Administratif ACR

En cas d'arrêt cardio-respiratoire, il est crucial dans eFibi de **rajouter le motif de recours aux secours « ACR »**. Cela va ouvrir le cahier ACR dématérialisé que vous devez obligatoirement **remplir en intégralité**.

<u>En cas de défaillance eFibi</u>, il faut utiliser le cahier ACR papier. Ensuite, après rédaction du rapport ADAGIO il est nécessaire d'envoyer par ailleurs un mail (dit « mail 11 points ») au service médical de groupement. Le mail est préparé automatiquement par ADAGIO lorsque l'utilisation spécifique « DSA » a été cochée en rédigeant le rapport. Relisez-le pour en vérifier les informations et les compléter au besoin.

OBJET : MESSAGE DSA

DESTINATAIRE : Service Médical de Groupement.

1. Numéro d'intervention ;

2. Code motif de départ ;

3. Adresse de l'intervention et commune (arrondissement pour Paris) ;

4. Dénomination de l'engin (ex : CRF 321 PLAI);

5. Heure de départ, date de départ;

6. Nom, prénom, date de naissance de la victime;

7. Devenir de la victime – Nom de l'AR sur place (ex : DCD, transport médicalisé parAR Ménilmontant …);

8. Hôpital et service de destination si transport (ex : Lariboisière – réanimation médicale) ;

9. Incident et/ou accident DSA lors de l'intervention (ex : présence de problème connexion électrodes, batterie faible, panne, arc électrique) ;

10. Problème de transmission (écrire : présence de problème ou absence de problème) ;

11. Numéro matricule et nom du chef d’agrès : CRF NIVOL NOM PRENOM ;

FIN DE VACATION

L'heure prévue de fin de vacation est indiquée pour information dès le début de la garde au stationnaire. Si l'équipage souhaite poursuivre la vacation au-delà des horaires conventionnés, l'Onyx doit avoir donné son accord au préalable.

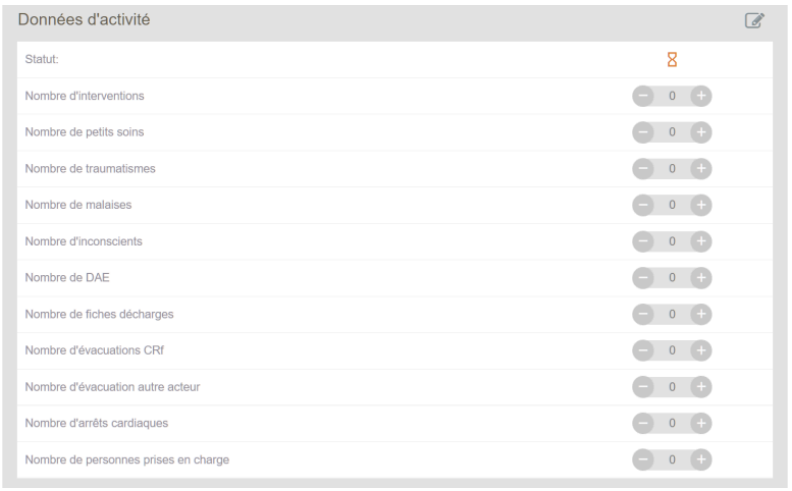
En fin de garde, le CIR BSPP se rend au PVO pour indiquer au stationnaire que l'équipage est indisponible (« indisponible manque de personnel »). Si l'équipage est en intervention, il ne passera pas le statut « disponible » à la fin de l'intervention ou en quittant l'hôpital (statut 25). Un appel par téléphone au PVO permettra d'indiquer l'indisponibilité.

Avant de finir la vacation, il est nécessaire de vérifier que tous les rapports de la journée sont validés : il peut parfois arriver qu'un rapport se mette en erreur après avoir été validé. Si des fiches d'intervention papier ont été réalisées (indisponibilité eFibi), les copies carbones des fiches d'intervention signées doivent être remises pour archivage au PVO.

Il est bien nécessaire de s'assurer de restituer au CS la bouteille d'oxygène prêtée ainsi que la radio et la tablette. Le VPSP peut être nettoyé et décontaminé au CS avec le matériel présent (seaux, balais, lingettes, etc.). Le réassort de matériel sera idéalement fait au local Croix-Rouge plutôt qu'au CS.

Le CIR BSPP s'assure que l'équipage puisse rentrer en sécurité à son domicile (prendre en compte l'horaire effectif de fin de la garde, les moyens de transport disponibles, l'éloignement des domiciles respectifs des équipiers, sans oublier le niveau de fatigue du CH). Il rappellera les consignes concernant l'interdiction de port de l'uniforme sur la voie publique si les bénévoles rentrent par leurs propres moyens.

Le CIR s'assurera de renseigner, sur Pegass, les informations concernant l'activité de la vacation. Il se rendra pour cela sur la mission, et devra remplir le bloc « données d'activité ».



Afin de participer à et favoriser la montée en compétences des équipiers, le CIR BSPP veillera à faire un retour par mail sur ses équipiers (CH inclus) auprès des DLUS concernés. Cela fait pleinement partie de son rôle de CI, favorisant la progression et montée en compétence des bénévoles qu'il encadre.

CONDUITES À TENIR ET PROCÉDURES PARTICULIÈRES

Panne ou accident de VPSP

En cas de **panne pendant un départ en intervention**, il est nécessaire en priorité de faire partir un autre engin pour honorer la demande de secours.

« De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, faites partir un autre engin (telle adresse) (tel motif), Croix-Rouge française 321 de Plaisance indisponible mécanique, Golf 3 parlez »

Puis si c'est nécessaire, une dépanneuse sera demandée par message ou par téléphone au CSO par la suite. Une convention signée entre la BSPP et la Croix-Rouge nous permet en effet d'être couverts par leur service interne de dépannage.

En cas de **panne survenant en évacuation**, la priorité est de demander un autre vecteur d'évacuation, et si nécessaire la dépanneuse :

« De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, je demande un moyen de transport non médicalisé et dépanneuse (adresse de la panne), Croix-Rouge française 321 de Plaisance indisponible mécanique, Golf 3 parlez »

Dans le cas où vous êtes **impliqués dans un accident de la circulation**, le message est un hybride entre le message de demande d'un autre engin pour votre intervention, et le message de renseignement / demande de moyen pour votre propre AVP :

« De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, faites partir un autre engin, (adresse de l'ordre de départ) pour (motif de l'ordre de départ), je demande l'officier de garde compagnie et Police (adresse de l'accident), Croix-Rouge française 321 de Plaisance impliquée dans un accident de la circulation avec 1 véhicule de tourisme, Golf 3 parlez »

Si il y a des blessé(s) (personnel CRf ou occupant du véhicule tiers) passer le message suivant:

« De la Croix-Rouge française 321 de Plaisance, faites partir un autre engin, (adresse de l'ordre de départ) pour (motif de l'ordre de départ), je demande l'officier de garde compagnie, un engin de prompt secours et Police (adresse de l'accident), Croix-Rouge française 321 de Plaisance impliquée dans un accident de la circulation avec X véhicule de tourisme / cycliste / motocycliste, X urgence(s) absolue(s) / relative(s) Golf 3 parlez »

Tout accident de la circulation impliquant un véhicule BSPP ou assimilé (donc CRf) est un motif de départ obligatoire de l'OGC et nécessitera donc de la part du CIR BSPP une demande Onyx en parallèle.

Plusieurs victimes / plusieurs engins

Il peut arriver sur une intervention que plusieurs engins se présentent pour prendre en charge une ou plusieurs victimes. La notion de Commandant des Opérations de Secours (COS) est alors importante. Bien qu'associatif, vous restez le COS si vous êtes le premier intervenant et tant qu'un autre chef d'agrès ou officier n'a pas officiellement repris ce rôle (message radio « *je prends le commandement des opérations de secours* »). Néanmoins dès que vous êtes impliqués sur une intervention complexe avec plusieurs engins, le COS sera assumé par un personnel BSPP (généralement le plus gradé). Dès lors, assurez-vous d'identifier le COS pour savoir auprès de qui prendre vos consignes.

Le COS étant le responsable de l'intervention dans son ensemble, il est le seul à passer des messages radios de demande de moyens et de renseignement. Il est conseillé pour ces messages, qui peuvent être assez longs, de se faire conseiller par un chef d'Agrès et de l'écrire sur papier avant de le transmettre. Si vous n'êtes pas ou plus le COS, vous n'aurez donc qu'à saisir votre statut « *transport hôpital* » et « *présentation hôpital* ».

Concernant les contacts à la coordination médicale, les bilans peuvent être passés en un bloc à la coordination, mais cela n'est pas une obligation.

Rappel : Il n'y aura qu'un rapport ADAGIO pour l'intervention, sur lequel interviendront plusieurs engins. Le rapport ne peut être validé que lorsque chaque engin aura validé sa partie. N'hésitez pas à vous faire conseiller au PVO pour le message de rentrée ainsi que le rapport ADAGIO.

Rappel : Vous pouvez, avec l'accord de la coordination médicale et en respectant le nombre maximal d'occupants dans le véhicule autorisé par les assurances, prendre en charge deux victimes si leur condition médicale le permet (position de transport notamment) et si cela est humainement possible (ne pas mettre une victime et son agresseur ensemble par exemple). Dans ce cas, le message de rentrée et le rapport ADAGIO devront bien comprendre les deux victimes.

Victime de forte corpulence

Le transport d'une victime de plus de 185 kg nécessite l'envoi d'un véhicule de transport bariatrique (VTBA), dont le matériel est adapté à cette situation (nos brancards ne sont en général pas homologués pour plus de 160 kg, voire 180 kg pour certains modèles).

Après avoir transmis son bilan à la coordination médicale, si l'évacuation est confirmée, et après s'être assuré d'être en mesure de procéder au brancardage sans besoin de renfort, alors le CI passera le message suivant :

« De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande le véhicule de transport bariatrique, (telle adresse), pour le transport d'une personne à forte corpulence, Golf 2 parlez ».

L'engin partant de la base de Limeil-Brévannes (94), voire d'un SDIS voisin, le délai de présentation peut être conséquent. Une fois la victime conditionnée à bord du véhicule, l'équipage CRf doit suivre le VTBA jusqu'à l'hôpital d'évacuation (le VTBA n'ayant pas de chef d'agrès, la victime reste sous votre responsabilité).

Plateforme d'interprètes de la BSPP

Il existe à la BSPP une plateforme d'interprètes (par le biais d'un service externalisé), pouvant être appelée par tout chef d'agrès rencontrant une difficulté linguistique dans la conduite de son bilan et de sa prise en charge.

Celle-ci peut être contactée au 01 53 26 52 80, complété du code 9719.

Découverte d'arme(s) ou de stupéfiant(s)

Lorsqu'une arme est utilisée comme telle, qu'elle soit une arme d'origine ou par destination, les secours devront sans délai demander l'intervention des forces de l'ordre pour maîtriser le ou les individus, quitte à faire une demande de Police d'urgence si l'équipage est menacé.

« De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande Police d'Urgence, (telle adresse), pour une personne armée menaçant les secours, Golf 2 parlez ».

En l'absence de notion de violence, le port ou le transport d'une arme ne constitue un délit pénal que pour des armes de certaines catégories. Le CIR BSPP contactera le sergent de jour pour s'enquérir de la conduite à tenir en fonction de l'arme. En tout état de cause, aucune victime armée ne doit être transportée vers l'hôpital : s'il y a lieu de réaliser une confiscation, la police devra être demandée quel que soit le type d'arme.

« De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande Police, (telle adresse), pour une personne armée nécessitant un transport en milieu hospitalier, Golf 2 parlez ».

En cas de découverte de stupéfiants en intervention et même s'il s'agit d'un délit pénal, les secours doivent, avant toute décision d'information des forces de l'ordre, faire coïncider la notion de dénonciation avec celle de secret

professionnel. Il faut faire la différence entre un simple consommateur, détenteur d'une faible quantité de drogue pour son usage personnel, et un passeur ou un trafiquant détenteur d'une quantité importante. Dans le premier cas, s'il y a un lien avec une victime, les secours doivent informer le médecin coordinateur de la suspicion de consommation. Dans le second cas, l'appel des forces de l'ordre doit être réalisé discrètement (appel téléphonique au PVO) mais sans délai, afin qu'elles réalisent la saisie de la drogue. En aucun cas la confiscation des produits stupéfiants ne sera réalisée par les secours.

Intervention sur un policier/gendarme / militaire / personnel du corps (BSPP)

Dans le cas d'une prise en charge sur un agent des forces de l'ordre ou un militaire (en service ou non, en uniforme ou non), le CIR BSPP s'assurera de prendre son grade, matricule, corps d'appartenance, lieu d'affectation et fonctions en plus de son identité. Si elle n'est pas déjà présente, il sera nécessaire de demander la Police afin qu'elle prenne en charge son arme de service le cas échéant:

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande Police, (telle adresse), secours à un fonctionnaire de police/gendarmerie/militaire/personnel du corps blessé/malade, Golf 2 parlez ».*

En complément le PVO sera contacté par téléphone, afin que l'OGC soit informé et décide ou non de se déplacer.

Pour les militaires, gendarmes, pompiers BSPP : le matricule, grade, corps/régiment, lieu d'affectation et fonctions seront notés puis indiqués dans le message de rentrée (voir exemple en annexe). Cela sera également précisé dans le rapport ADAGIO, s'il s'agit d'un pompier de la BSPP.

Relevé positif du détecteur de CO

Dans le cas d'un relevé positif du détecteur de CO, la première priorité consistera en la mise en sécurité de l'ensemble de l'équipage :

- Ouvrir des fenêtres si possible (visibles et accessibles en moins de 30 secondes aller/retour)
- Dégagement d'urgence des victimes si possible (visibles et accessibles en moins de 30 secondes aller/retour)
- Évacuation de l'équipage et prise en charge des premières victimes

Puis on passera le message suivant :

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, je demande un engin pompe et un détecteur multigaz pour un relevé positif au monoxyde de carbone, (telle adresse, tel étage), Bilan provisoire (X victimes Urgence Absolue, X victimes Urgence Relative), Golf 1 parlez »*

En cas de doute, le message *« je demande complément de départ pour un relevé positif au monoxyde de carbone »* pourra aussi être utilisé. Préciser également si un ou plusieurs personnels Croix-Rouge devaient présenter des symptômes d'intoxication (motif de déplacement de l'OGC et de l'Onyx).

D'autres messages plus complexes suivront au cours de l'intervention. Seront généralement engagés : un engin pompe, un personnel qualifié chef de garde à minima (possibilité qu'il s'agisse de l'officier de garde compagnie) et un détecteur multi gaz.

Personne menaçant de se jeter dans le vide ou tombée avec notion de hauteur

Pour une personne menaçant de se jeter dans le vide, le CIR BSPP appliquera les règles de sécurité et la conduite à tenir adéquates :

- Couper les avertisseurs sonores et lumineux au plus tôt

- Éloigner la foule et délimiter un périmètre de sécurité
- Aucun personnel sous le lieu de chute potentiel
- Un binôme en bas, non visible, avec le matériel de secours et prêt à agir
- Un binôme en haut, tentant de prendre contact avec la victime, sans se mettre en danger, sans la presser ou la brusquer

Le message à passer dès la présentation sera le suivant :

> *« De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, je demande complément de départ pour une personne menaçant de se jeter dans le vide, (telle adresse), Golf 1 parlez »*

Dans le cas d'une personne défenestrée ou tombée avec notion de hauteur importante, la conduite à tenir sera la suivante :

- Dès l'arrivée passer le message suivant :
  « De la Croix-Rouge française 901 de Montmartre, je demande complément de départ pour une personne tombée avec notion de hauteur, (telle adresse), Golf 1 parlez »
- Bilan circonstanciel rapide pour tenter de déterminer notamment la hauteur de chute
- Contact immédiat de la Coordination Médicale Urgente si chute supérieure à 3 mètres (équivalent à un étage)
- Appréciation de la conscience et de la respiration
- Si ACR : procéder au retournement si besoin et à la réanimation
- Si décès certain : faire une demande Police pour prise en charge d'un décès certain sur voie publique
- Hors ACR : ne pas mobiliser la victime sans avis médical (conduite à tenir secouriste sur polytraumatisé)

La demande de moyens permettra notamment de procéder à un repérage en étage pour exclure notamment le risque d'une autre victime potentielle.

NB : Il ne s'agit pas d'un motif de départ pour les véhicules associatifs. C'est normalement un engin pompe qui sera sonné pour ce type d'intervention. Néanmoins il est possible qu'un requérant appelle pour une « simple » personne blessée alors qu'il s'agit en réalité d'une chute de grande hauteur.

Intervention sous métro / RER / train

Les interventions sur les rails ne sont pas dans les grilles de départ des engins associatifs. Là encore, il s'agit de motifs de départ normalement réservés à un engin pompe. Il peut toutefois arriver que cela se produise, en raison d'un mauvais appel ou d'une situation qui a évolué le temps de l'arrivée des secours.

Si la victime a chuté sur les voies en station, il faudra demander depuis le téléphone en bout de quai la coupure urgente de courant sur toute la ligne (430 + numéro de la ligne de métro : 430 01 pour L1, 430 12 pour L12…).Faire également établir un périmètre de sécurité, et passer le message suivant :

> *CRF : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande complément de départ pour une personne tombée sur les voies, (telle station, telle ligne), et restons à disposition, Golf 2 parlez »*

Attention : en aucun cas, un équipier CRf ne descend sur les voies, tant que le courant n'a pas été coupé et la coupure vérifiée et confirmée par le régulateur de la ligne concernée. Sauf ACR ou urgence absolue, il conviendra en plus d'attendre les renforts BSPP qui descendront sur les voies en tenue de feu et poseront des court-circuiteurs pour assurer une sécurité la plus complète possible pour une intervention sur les voies, si celle-ci devait être nécessaire.

À savoir : si la radio ne passe pas, un téléphone en bout de quai est relié directement à la coordination médicale (68 118).

Intervention avec hélicoptère

La demande d'un hélicoptère pour l'évacuation d'une victime relève de la décision médicale. C'est un cas de contact systématique du sergent de jour et officier de garde compagnie, à minima pour conseils voire certainement déplacement de leur part et dans ce cas, prise de COS. Quitte à les appeler de manière anticipée, dès confirmation par la coordination médicale de la demande d'hélicoptère. Le message de renseignement sera passé ultérieurement.

Les zones de posés sont répertoriées sur les parcellaires BSPP et in fine, le choix de la zone appartient toujours au pilote de l'hélicoptère.

Pour information, il existe sur les radios ANTARES un canal dédié permettant de communiquer directement avec l'hélicoptère. Il sera utilisé par le COS pour coordonner la manœuvre au sol avec le pilote.

Dragon 75 est l'hélicoptère de la Sécurité Civile de Paris.

Demande du CO de libérer la fréquence SGAP OPS

En cas d'intervention importante, le CO ou le CSO peut être amené à demander de libérer la fréquence SGAP OPS afin que cette dernière se retrouve dédiée à l'opération en cours.

Le CIR BSPP sera informé par le PVO s'il est au Centre de Secours, ou par un message radio général du CSO auquel il ne faut pas répondre.

Dès réception de l'information, le CIR BSPP bascule de la fréquence SGAP-OPS-X à la fréquence OPS-X. Ceci, jusqu'à la levée de la consigne.

Plan rouge

La littérature des procédures est très fournie concernant les plans d'urgence à la BSPP et les messages qui y sont liés. Ce que le CIR BSPP doit retenir est le message permettant de déclencher un plan rouge ou un plan rouge alpha ; il permettra ainsi à la chaîne, complexe, de secours de se mettre en place et le commandement sera dès lors rapidement repris par des officiers.

Le plan rouge sera demandé dans une situation relativement circonscrite, où l'objectif est de mettre en place sur site une capacité de traitement de victimes et d'impliqués en nombre important. On peut considérer le plan rouge nécessaire à partir de 5 victimes UA.

Le message de demande est le suivant :

> *CRF : « URGENT URGENT URGENT Golf 2 ici la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, parlez »*
>
> *CSO : « Croix-Rouge française 101 de Chaligny ici Golf 2 parlez »*
>
> *CRF : « De la Croix-Rouge française 101 de Chaligny, je demande Plan Rouge, (telle adresse), (tel motif : fusillade nombreuses victimes…), bilan approximatif X UA, X UR, reconnaissance en cours, Golf 2 parlez »*

Si possible/nécessaire, préciser le chemin d'accès à utiliser par les engins qui seront envoyés en renfort.

La décision de déclencher un Plan Rouge ou Plan Rouge Alpha n'est pas du ressort du CI : c'est le CO qui prendra cette décision en fonction des éléments à sa disposition. Il n'y a donc pas de message spécifique pour cela.

Bien entendu, la première priorité du CIR BSPP reste la mise à l'abri de son équipage et la préservation de sa sécurité. Quant à la transmission du message, elle doit se faire au mieux mais personne ne reprochera un message imparfait dans une telle situation. L'essentiel est de passer une alerte correcte pour déclencher la bonne réponse.

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES (BSPP)

Coordination médicale : 01 58 57 51 02 (non urgent), 01 58 57 51 00 (urgent), 68118 (depuis le métro)
Numéro ECG : 01 58 57 51 15

CSO G1 (MTMA) : 01 53 11 83 18
CSO G2 (MASS) : 01 45 82 58 18
CSO G3 (CBVE) : 01 49 04 74 18

CO Champerret : 01 47 54 68 18

	CS	Sigle	Adresse	Arrdt	Téléphone
G1	Saint-Honoré	STHO	10 rue Sainte-Anne	1	01 59 59 08 81
	Blanche	BLAN	28 rue Blanche	9	01 59 59 08 80
	Château Landon	LAND	12 rue Philippe de Girard	10	01 59 59 09 40
	Boursault	BSLT	27 rue Boursault	17	01 59 59 09 11
	Montmartre	MTMA	12 rue Carpeaux	18	01 59 59 09 10
	Bitche	BITC	2 place Bitche	19	01 59 59 09 41
	Ménilmontant	MENI	47 rue Saint-Fargeau	20	01 59 59 09 70
	Charonne	CHAR	93 rue des Pyrénées	20	01 59 59 09 71
G2	Rousseau	ROUS	21 rue du Jour	1	01 59 59 13 80
	Sévigné	SEVI	7 rue de Sévigné	4	01 59 59 14 10
	Poissy	POIS	48-50 rue du Cardinal Lemoine	5	01 59 59 13 52
	Château d'eau	CHTO	50 rue du Château d'Eau	10	01 59 59 13 81
	Parmentier	PARM	87 avenue Parmentier	11	01 59 59 14 11
	Chaligny	CHLY	26 rue Chaligny	12	01 59 59 13 20
	Nativité	NATI	5 place Lachambaudie	12	01 59 59 13 21
	Masséna	MASS	37 boulevard Masséna	13	01 59 59 13 50
G3	La Monnaie	MONN	11 quai de Conti	6	01 53 10 24 28
	Colombier	COBI	11 rue du vieux Colombier	6	01 59 59 17 70
	Malar	MALA	7 rue Malar	7	01 59 59 17 71
	Port Royal	PROY	55 boulevard de Port-Royal	13	01 59 59 17 40
	Plaisance	PLAI	45 avenue Villemin	14	01 59 59 17 42
	Grenelle	GREN	6 place Violet	15	01 59 59 18 30
	Dauphine	DAUP	8 rue Mesnil	16	01 59 59 18 01
	Auteuil	AUTE	2-4 rue François Millet	16	01 59 59 18 31
	Champerret	CHPT	3 boulevard de l'Yser	17	01 59 59 18 00

NUMÉROS ET ADRESSES UTILES (HÔPITAUX)

Hôpital	SAU adulte	SAU pédia	Autres (🧠 = grande garde)	Accès SAU
15-20			Ophtalmo	28 rue de Charenton, 75012
Ambroise Paré	X	X		9 avenue Charles de Gaulle, 92100 Boulogne-Billancourt (pédia : 7ème étage)
André Grégoire	X			56 boulevard de la Boissière, 93100 Montreuil
Antoine Béclère		X	Gynéco/Obstétrique	157 rue de la Porte de Trivaux, 92140 Clamart
Armand Trousseau		X	Gynéco/Obstétrique	16 rue Lasson, 75012
Beaujon	X		Gynéco/Obstétrique, 🧠	100 bd du Général Leclerc, 92110 Clichy
Bichat	X		Neuro, gynéco/mater	46 rue Henri Huchard, 75018
Cochin	X		Traumato, ophtalmo	27 rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014
Cochin (site Port-Royal)			Gynéco/Obstétrique	123 boulevard de Port-Royal, 75014
HEGP	X		Main	37 rue du Professeur Florian Delbarre, 75015
Henri Mondor	X		Dermato, polytrauma, 🧠	51 av de Lattre de Tassigny, 94000 Créteil
Intercommunal de Créteil	X			40 avenue de Verdun, 94000 Créteil
Kremlin-Bicêtre	X	X	Neuro / 🧠, gynéco/Obstétrique	78 rue du Général Leclerc, 94270 Kremlin-Bicêtre
Pitié-Salpêtrière	X		Neuro / 🧠, gynéco, dentaire	83 boulevard de l'Hôpital, 75013
Lariboisière	X		ORL, Céphalées, 🧠	2 rue Ambroise Paré, 75010
Lariboisière			Gynéco/Obstétrique	41 boulevard de la Chapelle, 75010
Louis-Mourier			Gynéco/Obstétrique	178 rue de Renouillers 92700 Colombes
Maison-Blanche			Psy adulte (passer par SAU Lariboisière)	26 rue d'Hauteville, 75010
Necker		X	Gynéco/mater, ORL pédia, neuro pédia	149 Rue de Sèvres, 75015
Robert Debré		X	Gynéco/Obstétrique Main pédia	48 boulevard Sérurier, 75019
Rothschild			Neuro, ophtalmo	29 rue Manin, 75019
Sainte-Anne			Psy, neuro / 🧠	24 rue Broussais, 75014
Saint-Antoine	X		Main	34 rue Crozatier, 75012
Saint-Joseph	X		Gynéco/Obstétrique	185 rue Raymond Losserand, 75014
Tenon	X			53 rue Pelleport, 75020
Tenon			Gynéco/Obstétrique	4 rue de la Chine, 75020

CAS DE CONTACT ET DÉPLACEMENT DE L'ONYX

Ces listes sont présentées pour rappel, elles sont fixées par note de service de la Direction Territoriale. En cas de différence de version, la note de service prime.

Motifs de contact Onyx

- Intervention avec plus de 3 véhicules de secours (CRf, BSPP ou SAMU)
- Déplacement d'un moyen inhabituel (Moyen Élévateur Aérien, GRIMP, Hélicoptère…)
- Intervention avec 3 victimes prises en charge simultanément par la CRf
- Intervention sur une personnalité (politique, médiatique…)
- Arrêt cardiaque avec décès certain à l'arrivée des secours
- Décès d'une victime prise en charge par la CRf
- Intervention nécessitant un complément urgent de balisage
- Accident grave de la circulation (avec moyen médicalisé, Camion de Désincarcération et/ou Brigade Accident)
- Intervention particulièrement déstabilisante (physiquement ou psychologiquement)
- Non-conformité d'un équipage à la prise de service
- Demande particulière de nos partenaires (ex : transfert secondaire entre deux hôpitaux)
- Immobilisation d'un VPSP suite à un problème technique
- Sur demande du responsable de l'intervention

Motifs de déplacement Onyx

En complément des cas d'information du cadre de permanence, pour lesquels il décide ou non de se déplacer, il existe des cas où le déplacement de l'Onyx est obligatoire :

- Utilisation du DSA
- Accident (matériel ou corporel) de la circulation mettant en cause la CRf
- Secouriste blessé nécessitant un transport en milieu hospitalier
- Ouverture d'un DPS non déclaré à la Préfecture et/ou non déclaré sur PEGASS
- Ouverture d'un DPS avec risque particulier non signalé sur la convention (public à risque, environnement dangereux…)
- Sur un PAPS dès la deuxième demande de moyen d'évacuation
- Sur un DPS sans moyen d'évacuation, lors de la quatrième demande de moyen d'évacuation
- Incapacité à contacter une équipe pendant plus de 2h
- Prise en charge d'une personnalité
- Déplacement d'un OPJ, du Service de Traitement Judiciaire des Accidents
- Déplacement du représentant d'un service public ou privé (Commissaire, Maire…)
- Déplacement de l'Officier de Permanence BSPP
- Présence des médias
- Problème relationnel important avec un tiers (SAMU, BSPP, famille, témoin, autre service publique…) sur demande de la personne concernée (Chef de salle, CI, PSE2…).
- Incident impliquant la CRf d'un autre département en mission / passage sur Paris.

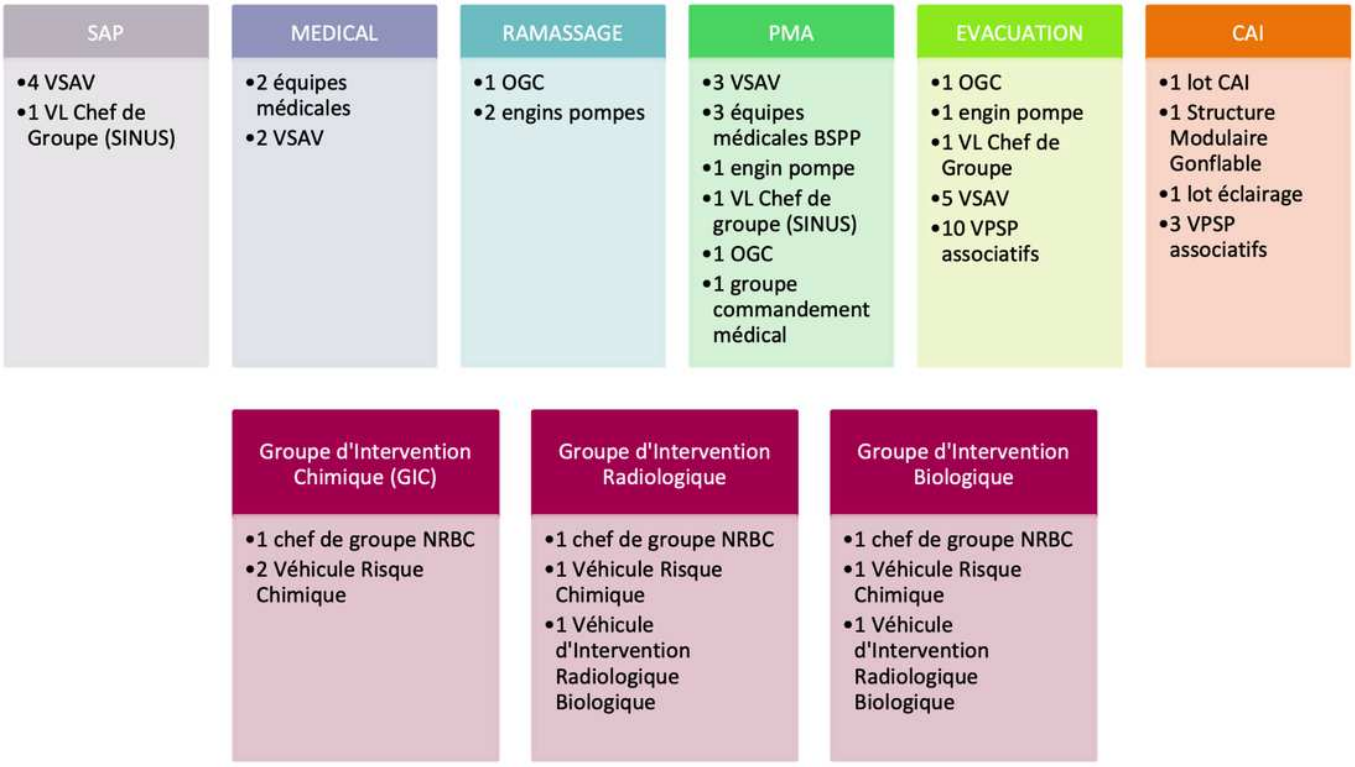
ANNEXE : LES GROUPES BSPP

Dans le cadre de la gestion des événements particuliers, la BSPP définit des « groupes » qui rassemblent, de façon standardisée, un certain nombre d'engins de manière à traiter une problématique spécifique. Cela permet de demander un groupe plutôt que d'énumérer un à un les engins nécessaires, et clarifier à la fois la prise de décision et les transmissions.

Les différents plans, notamment le plan rouge et le plan rouge alpha, englobent à leur tour plusieurs groupes.

Il en existe un certain nombre (tous détaillées dans le BSP 118.1). Il ne vous est pas demandé de les connaître, mais cela peut être un plus pour la compréhension et le positionnement dans le cadre d'une situation exceptionnelle.

Les groupes principaux en secours à victime sont les suivants :



À noter qu'un VPSP CRf en garde au sein d'un CS pourrait être employé dans le cadre d'un groupe. Cela se fera à l'appréciation du CSO. S'il est peu probable que ce soit le cas sur un feu, ce serait par contre envisageable sur un AVP.

Un groupe se demande de la façon suivante : *« Je demande un groupe (intitulé du groupe), telle adresse »*.

ANNEXE : STATUS ANTARES

Code	Statut
1	Parti
2	Sur les lieux
3	*Message (inusité)*
4	*Message urgent (inusité)*
5	Transport hôpital
6	Arrivée hôpital
7	Disponible
8	Indisponible
9	Rentré
25	Quitte l'hôpital
41	Demande de confirmation
47	Présentation spontanée

ANNEXE : EXEMPLES DE MESSAGES DE RENTRÉE

Victime militaire (armée de terre, gendarme, personnel de la BSPP, etc.) :

1/ Bilan, contact (préciser le niveau de votre interlocuteur : opérateur coordination, infirmier coordination ou médecin coordinateur), décharge (le cas échéant)
2/ Grade, nom, prénom, âge, sexe, état, numéro d'incorporation (matricule), unité de rattachement et fonctions ; transporté par CRF XXX vers SAU XXX (ou LSP, le cas échéant)
5/ Néant
CRI 320

Si l'équipage prend un charge un militaire, il conviendra d'en rendre compte immédiatement le PVO du CS concerné, afin que l'officier de garde compagnie soit avisé.

Intervention annulée par le centre opérationnel :

1/ Néant
5/ Néant
CRI 004

Identité d'une victime inconnue (cas d'une ébriété) :

1/ Bilan, contact (préciser le niveau de votre interlocuteur)
2/ Un homme d'âge et d'identité inconnus, UR, transporté par CRF XXX vers SAU XXX
5/ Néant
CRI 310

Pas de victime trouvée, malgré une demande de confirmation d'appel et d'adresse

1/ Recherche
5/ Néant
CRI 919 *(sans remplir une fiche bilan)*

Message de rentrée secondaire : renfort brancardage

1/ Brancardage
2/ Néant
CRI : SEC (pour secondaire)

ANNEXE : LES CODES RETOURS INTERVENTION (CRI)

Une liste complète des CRI est disponible au PVO, n'hésitez pas à la consulter ou à vous faire conseiller pour des interventions inhabituelles.

(0…) Fausses alertes

001 Fausse alerte erreur
004 Intervention annulée par le CO
009 Autres fausses alertes

(2..) Intervention concernant la circulation

(20.) Évènement concernant la circulation sans intervention de notre part

200 Accident de circulation traité avant notre arrivée
201 Accident de circulation pris en charge par un service public
202 Accident de circulation du ressort d'un organisme privé ou un tiers

(21.) Secours routier avec désincarcération

(22.) Secours routier sans désincarcération

220 Piéton victime d'un accident de la circulation
221 Concernant un deux roues sur voie rapide
222 Concernant un véhicule de tourisme sur voie rapide
223 Concernant un poids lourd sur voie rapide
224 Concernant un deux roues sur d'autres voies de circulation
225 Concernant un véhicule de tourisme sur d'autres voies de circulation
226 Concernant un poids lourd sur d'autres voies de circulation
227 Concernant des véhicules différents (VL et VL, PL et PL, VL et PL, etc.) sur voies rapides
228 Concernant des véhicules différents (VL et VL, PL et PL, VL et PL, etc.) sur d'autres voies de circulation
229 Autres interventions concernant le secours routier sans désincarcération

(29.) Autres interventions

290 Autres interventions concernant la circulation

(3..) Secours à victimes

(30.) Évènements sans mise en oeuvre de nos moyens

300 Traité avant notre arrivée
301 Traité ou du ressort d'un service public
302 Traité ou du ressort d'un organisme privé (ou un tiers)

(31.) Secours à victime(s) intoxiquée(s)

310 Intoxications

(32.) Secours à victime(s) prise(s) de malaise

320 Affection(s) médicale(s)

(33.) Dégagement de victime(s)

336 Tombée sur la voie (métro)
337 Tombée sur la voie (RER et autre réseau ferré)
338 Tombée sur la voie (Tramway)

(34.) Transport et/ou brancardage - relevage

340 Transport de victime(s)
341 Brancardage de victime(s)
342 Transport et brancardage de victime(s)
343 Relevage de personne impotente
344 Relevage et brancardage de patient « grand obèse » (> 150 kg)

(35.) Secours à victime(s) blessée(s)

350 Par explosion
351 Par effondrement, éboulement, etc.
352 Par arme à feu (hors suspicion d'agression)
353 Par arme blanche (hors suspicion d'agression)
354 Par piqûres ou morsures d'animaux
355 Par brûlures (autre que brûlé du fait d'un incendie)
356 Par chute
357 Par pièce d'artifice ou pétard
358 Par coupure (autre que par arme blanche)
359 Autres interventions concernant le secours à victime(s) blessée(s)

(36.) Suffocation mécanique, submersion, électrocution...

360 Pendaison, strangulation, suffocation
361 Noyade, submersion
362 Électrocution, électrisation
363 Foudroiement
364 Écrasement, compression (par masses importantes)
369 Autres interventions concernant la suffocation mécanique, submersion, électrocution, etc.

(38.) Divers

380 Personne décédée, constat sans autre indication

(39.) Agressions ou autres interventions concernant le secours à victime(s)

390 Secours à victime(s) blessée(s) par arme à feu avec suspicion d'agression
391 Secours à victime(s) blessée(s) par arme blanche avec suspicion d'agression
399 Autres interventions concernant le secours à victime(s)

(4..) Assistance à personnes (Pas de soins apportés)

(40.) Assistance à personne sans intervention de notre part

400 Assistance à personne effectuée avant notre arrivée
401 Assistance à personne effectuée par un service public
402 Assistance à personne effectuée par un tiers.

(45.) Pas une victime

451 Pas une victime mais avec notion de vulnérabilité (SDF, personne âgée, sourde, retrouvée dehors par grande chaleur ou froid, personne étrangère...) et réalisation d'un bilan
452 Pas une victime sans notion de vulnérabilité

(49.) Autres formes d'assistance à personne

490 Autres assistances à personne.

(9..) Reconnaissances et Recherches

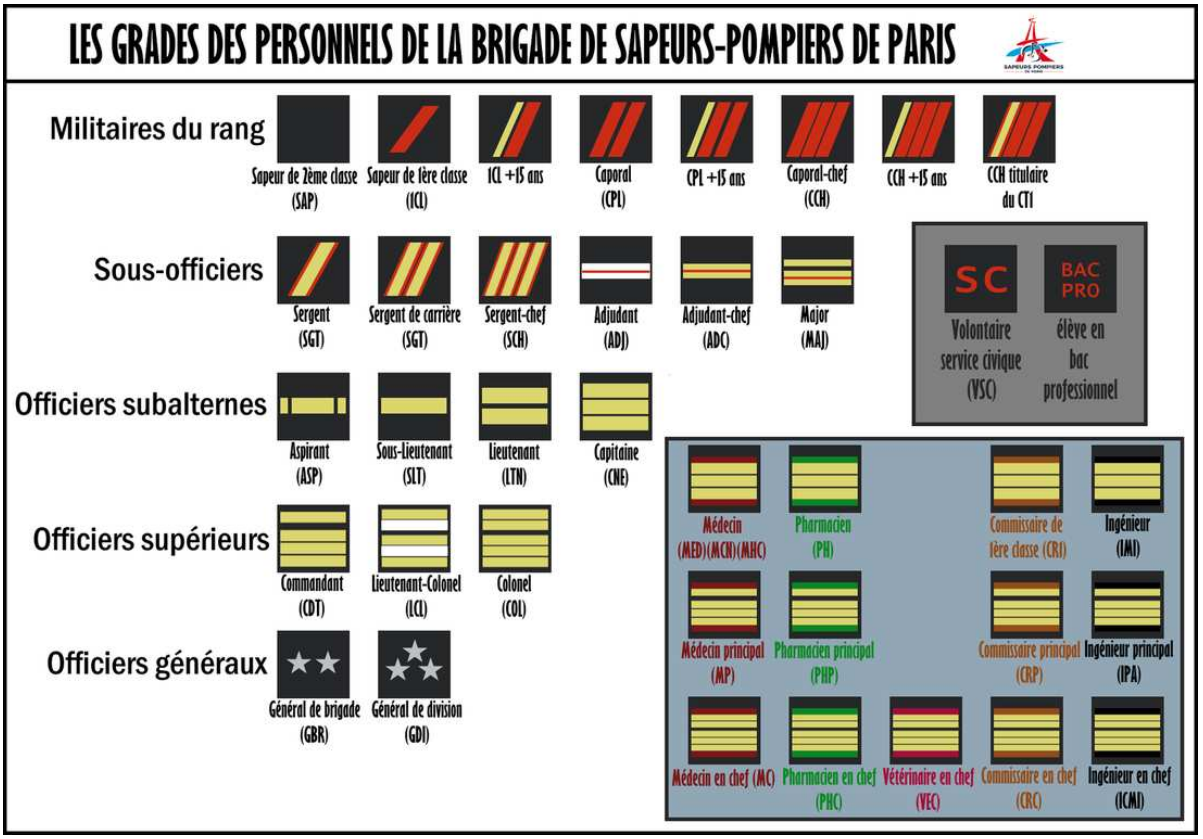
(93.) Reconnaissances

939 Autres recherches ou reconnaissances

ANNEXE : CAS CONTACT OGC (NON EXCLUSIFS) LIÉS AU CONTEXTE TERRORISTE ET SOCIAL

- Agression à l'arme à feu ou à l'arme blanche
- Agression envers les secours
- Intervention concernant un militaire/policier/agent de la PP/VIP
- Attaque délibérée / comportement suspect aux abords d'un CS
- Intervention dans un site bénéficiant d'un détachement de SPP
- Personne retranchée
- Intoxication au CO avec victime
- SUAP dans un bar / boîte de nuit (plusieurs UA/UR)
- Intervention dans des gares suite aux mouvements sociaux, évacuation de rames
- Piéton renversé par un VHL (se limiter au cas où le véhicule a quitté les lieux de l'accident / dans un ERP)
- Découverte de dispositif de mise à feu y compris bouteille de gaz dans un VHL
- Plusieurs feux VP (hors VU)
- Personnes blessées par un artifice ou suite à la manipulation d'artifices laissés sur le terrain
- Intervention ayant des conséquences directes et durables sur les réseaux (transports, fluides, etc.)
- Intervention de longue durée (plus d'1h30 sans message de renseignement)
- Demande d'engins ou de matériels spécifiques (CD, DEP, MEA pour brancardage, VIMP, VRA, VTBA, VPS, VRCH ou encore matelas de sauvetage, Altair 4X, boîte électro-secours, etc.)
- SDF UA ou DCD VP ou lieu public

ANNEXE : LES GRADES À LA BSPP



Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grades_des_personnels_de_la_BSPP.png

ANNEXE : LES TYPES D'ENGINS À LA BSPP

Vous trouverez une présentation plus complète des engins de la BSPP en ligne : https://pompiersparis.fr/nos-engins/

Moyens sanitaires du quotidien



Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes



Ambulance de Réanimation

Moyens sanitaires exceptionnels



Véhicule Liaison Radio Directeur des Secours Médicaux



Véhicule d'Accompagnement Santé



Véhicule de Remise en Condition du Personnel

Engins Pompes



Premier-Secours Évacuation 5e Génération



Fourgon Pompe-Tonne Desautel®



Fourgon d'Appui

Moyens Élévateurs Aériens



Échelle Pivotante Automatique à Nacelle



Échelle Pivotante Automatique



Bras Élévateur Aérien Automobile

Moyens Spéciaux



Véhicule de Protection et de Signalisation



Camion Désincarcération



Dépanneuse

ANNEXE : GLOSSAIRE

ACROPOL – Automatisation des Communications Radio-Opérationnelle de la Police

ADAGIO – Application Diffusion Alerte et Gestion Informatisée des Opérations

ANTARES – Adaptation National des Transmissions Aux Risques Et aux Secours

AR – Ambulance de Réanimation

ARI – Appareil Respiratoire Isolant

ARS – Agence Régionale de Santé.

BEA – Bras Elévateur Aérien

BOPO – Bureau OPErations

BSP – Brigade Sapeurs-Pompiers (Documentation)

BSPP – Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris

CB – Croix Blanche

CD – Camion de Désincarcération

CESD – Camion d'Étaiement et de Sauvetage-Déblaiement

CFS – Centre Français du Secourisme

Cie — Compagnie

CI – Chef d'Intervention

CIR – Cellule d'Identification Radiologique

CMIC – Cellule Mobile d'Intervention Chimique

CMIR – Cellule Mobile d'Intervention Radiologique

CO – Centre Opérationnel (salle 18 incluant CTA 18/112)

COGIC – Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise

COS – Commandant Des Opérations De Secours

CRAC – Camionnette de Réserve d'Air Comprimé

CRC – Cellule de Reconnaissance Chimique

CRF – Croix Rouge Française

CRI – Compte Rendu d'Intervention

CRR – Cellule de Reconnaissance Radiologique

CRS – Compagnie Républicaine de Sécurité

CS – Centre de Secours

CSO – Centre de Surveillance Opérationnel (groupement)

CSTC – Centre de Secours Territorialement Compétent

DAP – Détachement À Pied

DEP – Dépanneuse

DN – Départ Normal

DOPC – Direction de l'Ordre Public et de la Circulation

DOS – Directeur des Opérations de Secours

DSA – Défibrillateur Semi-Automatique

DSM – Directeur Des Secours Médicaux

EDF – Électricité De France

EM – État-Major

EP – Engin-Pompe

EPA – Échelle Pivotante Automatique

EPAN – Échelle Pivotante Automatique à Nacelle

EPI – Équipement de Protection Individuelle

EPSA – Échelle Pivotante Semi-Automatique

ER – Établissement Répertorié

ERE – Élément de Reconnaissance et d'Évaluation

ERP – Établissement Recevant du Public.

F – Fourgon

FA – Fourgon d'Appui

FM – Fourgon Mixte

FMA – Fiche Médicale de l'Avant

FNPC – Fédération Nationale de Protection Civile

FPT – Fourgon Pompe Tonne

F-SMG – Fourgon-Structure Modulaire Gonflable.

GDF – Gaz De France

GREP – Groupe de Recherche et d'Exploration Profonde

GRIMP – Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieux Périlleux

INTERFER – Intervention Ferroviaire (plan de secours)

LCPP – Laboratoire Central de la Préfecture De Police

LOG – Logistique

MAJ – Mise à jour

MCC – Médecin coordinateur contacté

MCE – Massage cardiaque externe

MGO – Marche générale des opérations

MTNM – Moyen de transport non médicalisé

NRBC-E – Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique, Explosif

ODE – Ordre De Départ

OPJ – Officier de Police Judiciaire

OM – Ordre de Malte

OPC – Officier Poste de Commandement

OPCM – Officier Poste de Commandement Médical

ORSEC – Organisation de la Réponse de SEcurité Civile

PC – Protection Civile

PC – Perte de Connaissance

PCTAC – Poste de Commandement Tactique

PEV – Protection Éclairage Ventilation

PMA – Poste Médical Avancé

PPP – Préfecture de Police de Paris

PRV – Point de Rassemblement des Victimes

PS – Premier-Secours

PSE – Premier-Secours Évacuation

PST – Premier-Secours Tonne

PVO – Poste de Veille Opérationnelle

RATP – Régie Autonome des Transports Parisiens

RER – Réseau Express Régional

SAMU – Service d'Aide Médicale Urgente

SDIS – Service Départemental d'Incendie et de Secours

SGAP – Secrétariat général pour l'administration de la police (canal)

SGAP-OPS – Secrétariat général pour l'administration de la police opérations (canal)

SINUS – Système d'Informations NUmérique Standardisé

SIS – Spécialiste Intervention Subaquatique

SMG – Structure Modulaire Gonflable

SMUR – Service Mobile d'Urgence et de Réanimation

SP – Sapeur-Pompier

TPH – Terminal portatif hertzien

UMH – Unité Mobile Hospitalière

UA – Urgence Absolue

UR – Urgence Relative

VAS – Véhicule d'Accompagnement Santé

VID – Véhicule d'Interventions Diverses

VLR – Véhicule de Liaison Radio

VP – Voie Publique

VPC – Véhicule Poste de Commandement

VPSP – Véhicule de Premiers Secours à Victimes

VSAV – Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes

ZDI – Zone de Déploiement Initial

ANNEXE : HISTORIQUE DU DOCUMENT

La version actuelle du guide, produite en mai 2025, a été mise à jour par : François-Xavier Coudert, Arnaud Crespeau, Sibylle de Ferrière, Zakaria Mahdi.

La version précédente de ce référentiel a été rédigée en août 2017 par Selim Miled, et mise à jour en novembre 2018 par Océane Raynaud. Il a été validé le 30 novembre 2017 en réunion des chefs de salle ainsi que par Jean-Yann Ogée, Directeur Territorial de l'Urgence et du Secourisme. Ont contribué à la rédaction et à la relecture de la version 2017 : Cyril Bonnet, Christophe Champeaux, William Fortin, Saïd Khemliche, Thomas Leleu, Antoine Marquaille, Kevin Nabais-Dias, Laurent Olivier, et Audrey Roumegous.

Rédacteurs et contributeurs des versions précédentes (de 2006 à 2016) : Ludovic Tessier, Cyril Bonnet, Fleur Billebocq, Frédérique Brayda, Patrick Castagne, Guillaume Constantin, Jérôme Deschamps, Jonathan Marie, Dr Nicolas Segal, Stéphanie Sergent, Alain Vais, CNE Gautier Delagorge, et Laurent Simeoni.